



PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT

FB-EM-POA-PL22001

Rev.	Data da Revisão	Elaborado por:	Revisado por:	Validado por:	Aprovado por:
02	13/09/2024	G.Vieira	R. Pereira	R. Pereira	C.Schmid

[illegible]

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 2 de 106

Controle de Revisão		
Revisão	Data	Descrição da Mudança
00	22/08/2022	Emissão inicial.
01	20/10/2022	Atualização Anexo I – Relação de Contatos Inclusão Anexo XVI
02	13/09/2024	Atualização Anexo I – Relação de Contatos Atualização Marco Legal Atualização Item 11.4 (2) Atualização Anexo II Atualização Anexo III Atualização Anexo IV Inclusão Anexo XV

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 3 de 106

APRESENTAÇÃO

- (1) O termo emergência de saúde pública de importância internacional é definido no Regulamento Sanitário Internacional - RSI (2005), como: Evento extraordinário, o qual é determinado:
 - a) por constituir um risco de saúde pública para outro Estado por meio da propagação internacional de doenças;
 - b) por potencialmente requerer uma resposta internacional coordenada.

- (2) A estratégia de enfrentamento de Emergências em Saúde Pública (ESP) não deve estar focada apenas na resposta, mas sim na prevenção e proteção da população vulnerável às ameaças identificadas. Conhecer o perfil de risco da localidade e o desenvolvimento das capacidades básicas do Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005) para o Ponto de Atuação e para a região são fundamentais para a efetividade da resposta em uma Emergência.

- (3) Este modelo está de acordo com Guia da Organização Mundial da Saúde (OMS), as diretrizes do Mercosul, bem como normas e orientações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/Ministério da Saúde - MS. Orienta-se que o plano esteja também alinhado com os planos de contingência da SMS e SES.

- (4) O Plano de Contingência para ESP do Ponto de Atuação constitui uma etapa da preparação para Emergências em Saúde Pública no qual é realizada uma previsão de riscos, coordenando e integrando esforços das instituições envolvidas e partes interessadas. Essa etapa formal é concluída com a divulgação do Plano a todos os envolvidos, realização de exercícios e revisão regular, minimamente a cada ano, quando houver mudanças significativas na legislação ou políticas relativas à Saúde Pública.

- (5) Orienta-se que a apresentação registre as instituições envolvidas e as principais alterações da versão atual histórico de versões, capacitações e exercícios. Caso não se trate da primeira versão, registre ainda as capacitações e exercícios realizados e eventuais necessidades de novas capacitações e exercícios.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 4 de 106

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	6
1.1	PERFIL DE RISCO	6
1.2	RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS	6
2	OBJETIVOS	6
3	MARCO LEGAL	7
4	CONCEITOS E DEFINIÇÕES.....	12
5	ABREVIATURAS.....	19
6	RESPONSABILIDADES.....	21
7	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	21
8	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	21
9	CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA	21
10	RESPOSTA OPERACIONAL	22
11	FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES	23
11.1	HOSPITAL DE REFERÊNCIA.....	30
11.2	MEIOS DE ACIONAMENTO	31
11.3	PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	31
11.3.1	Atribuição.....	31
11.4	ATENDIMENTO AOS FAMILIARES DOS PASSAGEIROS	32
11.5	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁREAS	33
11.6	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL INFECTANTE/INFECTADO)	33
12	CÓDIGOS OU FASES DE ALERTAS FORMAIS	33
12.1	AVALIAÇÃO DE RISCO.....	34
12.2	EVENTO COM INDIVÍDUO.....	34
12.3	EVENTOS AMBIENTAIS	35
12.4	ATIVAÇÃO DO PLANO.....	35
12.5	DESATIVAÇÃO DO PLANO	36
13	DISPOSIÇÕES FINAIS.....	36
14	RELAÇÃO DE ANEXOS	37
	ANEXO I - Relação de Contatos.....	38
	ANEXO II - Fluxogramas de Acionamentos	47
	ANEXO III - Mapa de Grade Interno do Aeroporto	49
	ANEXO IV - Croqui das Áreas de Triagem e Isolamento.....	50

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 5 de 106

ANEXO V - Protocolo Operacional Padrão	51
ANEXO VI - Procedimento: Limpeza e Desinfecção de Ambientes, Equipamentos, Utensílios Potencialmente Contaminados, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários	70
ANEXO VII - Procedimentos para as Ações a Serem Realizadas Conforme os Critérios da OMS 74	
ANEXO VIII - Fluxo de Testagem em Aeroportos	77
ANEXO IX - Ficha PLEM	78
ANEXO X - Ofício da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria Municipal de Saúde com Orientações para a Barreira Sanitária	79
ANEXO XI - Ação de Controle Sanitário e Rastreamento de Variantes do Sars-Cov-2 no Aeroporto Internacional Salgado Filho - Procedimentos e Resultados.....	81
ANEXO XII - Nota Técnica Sobre a Variante Delta.....	98
ANEXO XIII - Reunião de Alinhamento Anvisa /SMS/Fraport - Controle Sanitário Aeroporto POA.....	101
ANEXO XIV - Ofício-Circular nº. 02/2022 - ANVISA - Procedimentos em caso de contaminação pelo vírus Monkeypox.....	103
ANEXO XV - Ofício-Circular nº. 15/2024 - ANVISA - Encaminha a Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA - Atualização de medidas em pontos de entrada frente à vigilância de casos de mpox na Região da África.	106

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 6 de 106

1 INTRODUÇÃO

- (1) Este documento, instituído pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e Fraport Brasil, é denominado plano de atendimento à Evento de Interesse à Saúde Pública do Porto Alegre *Airport*, foi adequado/adaptado pelo Gestor de Resposta à Emergência Aeroportuária, de acordo com a realidade do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, as legislações e normas em vigor e tem por finalidade definir a participação da Comunidade Aeroportuária e das Organizações, internas e externas a este Aeroporto, bem como estabelecer os procedimentos básicos necessários às ações a serem desenvolvidas, por parte dos integrantes deste Plano para atendimento às emergências de saúde pública de interesse local, nacional ou internacional.

1.1 PERFIL DE RISCO

- (1) Registre os principais riscos a que o ponto de atuação está sujeito, relacionados ao fluxo de meios de transporte nacionais e internacionais, doenças e riscos presentes na região etc. Registre o estado atual das capacidades básicas do Ponto de Atuação.

1.2 RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS

- (1) Identifique os elementos que já estão presentes em outros planos ou documentos como o PLEM do Aeroporto, Plano Estadual de Saúde, Plano de Resposta a Emergência do Ministério da Saúde, Plano de Segurança Aeroportuário - PSA, dentre outros, e que serão adotados na resposta a Emergências em Saúde pública, **garantindo a interoperabilidade do plano.**

2 OBJETIVOS

- (1) **Geral:** Nortear as ações de emergência e vigilância em saúde no **Porto Alegre Airport**, este definido como um dos pontos de entrada de importância internacional do país e do estado do Rio Grande do Sul, frente à ocorrência de eventos de interesse à saúde pública.
- (2) Controlar e dar resposta de Saúde Pública oportuna contra a propagação de doenças e outros eventos de importância à saúde pública, de maneira proporcional e restrita aos

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 7 de 106

riscos (químicos, biológico, radiológico e nuclear - QBRN) no âmbito do Porto Alegre *Airport* e que evitem interferências desnecessárias com tráfego e com o comércio.

(3) **Específicos:**

- a) definir atribuições;
- b) delimitar as áreas de atuação e responsabilidades do Porto Alegre *Airport*;
- c) facilitar a interação e integração de todas as entidades participantes;
- d) definir os pontos focais dos órgãos, empresas e setores envolvidos na resposta a eventos de saúde pública;
- e) definir as atribuições e responsabilidades dos órgãos, empresas e setores envolvidos nas ações de resposta rápida a eventos de Saúde Pública;
- f) estabelecer critérios e procedimentos de ativação e desativação do Plano de Contingência para Eventos de Saúde Pública (PCESP);
- g) estabelecer os fluxos de comunicação de eventos de saúde pública;
- h) estabelecer protocolos e procedimentos para uma resposta oportuna frente à Emergência em Saúde Pública;
- i) definir a rede de assistência (hospitais de referência e serviço de remoção) e fluxos para atendimento frente a eventos de Saúde Pública;
- j) difundir o PCESP à comunidade aeroportuária;
- k) capacitar a comunidade aeroportuária quanto a aplicação do PCESP;
- l) realizar simulados.

3 MARCO LEGAL

O presente Plano foi elaborado em consonância com as seguintes legislações e normas:

- (1) **Regulamento Sanitário Internacional - RSI (2005).**
- (2) **Lei n.º 7.565, de 19/12/86** - Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
- (3) **Resolução 382, de 14/06/16** - Estabelece em seus vários assuntos, critérios regulatórios quanto ao Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária (SREA) em aeródromos civis.
- (4) **Doc. N.º 9137** - NA/898 - Parte 7 - 1991 - 2ª Edição - Manual de Serviços de Aeroportos - Planejamento de Emergência nos Aeroportos.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 8 de 106

- (5) **MP 12.04 (SEA)**, em vigor - Atendimento Médico de Emergência em Aeroporto.
- (6) **Portaria Ministério da Saúde nº 950, de 15/05/2012** - Requisitos Mínimos para Elaborar Planos de Contingências para Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em Pontos de Entrada Designados pelos Estados Partes do Mercosul segundo o RSI (2005).
- (7) **Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977** - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
- (8) **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990** - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (9) **Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999** - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
- (10) **Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975** - Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
- (11) **Lei nº 13.730, de 8 de novembro de 2018** - Altera o Art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para considerar infração sanitária a inobservância das obrigações nela estabelecidas.
- (12) **Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017** - Institui a Lei de Migração.
- (13) **Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017** - Regulamenta a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração.
- (14) **Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940** - Código Penal - Capítulo III - dos Crimes contra a Saúde Pública.
- (15) **Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011** - Dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 9 de 106

- (16) **Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011** - Regulamenta, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS).
- (17) **Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09** - Visa prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública, e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais.
- (18) **RDC ANVISA nº 21, de 28 de março de 2008** - Dispõe sobre a Orientação e Controle Sanitário de Viajantes em Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.
- (19) **Portaria Ministério da Defesa nº 585 de 07 de março de 2013** - Aprova as Diretrizes de Biossegurança, Bioproteção e Defesa Biológica do Ministério da Defesa.
- (20) **Portaria nº 1.139, de 10 de junho de 2013** - Define, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes Nacionais para Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.
- (21) **Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017** - Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde.
- (22) **Portaria nº 1.378, de 9 de julho de 2013** - Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- (23) **RDC ANVISA nº 02, de 08 de janeiro de 2003** - Regulamento Técnico, para fiscalização e controle sanitário em aeroportos e aeronaves.
- (24) **RDC ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 10 de 106

- (25) **Resolução nº 255, de 13 de novembro de 2012** - Estabelece regras sobre a disponibilização de Informações Antecipadas sobre Passageiros (API) e do Registro de Identificação de Passageiros (PNR).
- (26) **Lei nº 11.182 de 27 de setembro de 2005** - Cria a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá outras providências.
- (27) **Decreto nº 7.554 de 15 de agosto de 2011** - Dispõe sobre a coordenação das atividades públicas nos aeroportos, institui a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias - CONAERO e as Autoridades Aeroportuárias.
- (28) **Resolução ANAC Nº 382, de 14 de junho de 2016** - Aprova a Emenda nº 01 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 153, altera as Resoluções nºs 25, de 25 de abril de 2008, e 279, de 10 de julho de 2013, e revoga as Resoluções nos 234, de 30 de maio de 2012, e 236, de 5 de junho de 2012.
- (29) **Resolução ANAC Nº 400, de 13 de dezembro de 2016** - Dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo.
- (30) **Resolução RDC nº 307, de 27 de setembro de 2019** - Aprova os Requisitos Mínimos para Elaborar Planos de Contingência para Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em Pontos de Entrada Designados pelos Estados Partes Segundo o RSI (2005).
- (31) **Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020** - Promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005.
- (32) **Portaria GM/MS nº 3523 de 28 de agosto de 1998** - Aprova Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 11 de 106

- (33) **ABNT, NBR-17.037/2023 – Qualidade do Ar Interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente – padrões referenciais**, trata sobre “Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso Público e Coletivo.
- (34) **Resolução RDC nº 622, de 9 de março de 2022** - Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências.
- (35) **Resolução RDC nº 661/2022** - Dispõe sobre as Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.
- (36) **Resolução RDC nº 662/2022** - Dispõe sobre o controle e fiscalização sanitária do traslado de restos mortais humanos em portos, aeroportos e fronteiras.
- (37) **Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022** - Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN).
- (38) **NOTA TÉCNICA Nº 13/2023/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA**. Manifestação técnica frente a ocorrência de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves, e orientações para vigilância epidemiológica em humanos, em Portos, Aeroportos e Fronteiras.
- (39) **NOTA TÉCNICA Nº 14/2023/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA**. Atualização quanto alerta para risco de reintrodução da poliomielite no Brasil perante a situação de poliovírus derivado vacinal tipo 1 (PVDV1) no Peru e recomendações para ações de Vigilância Epidemiológica das Paralisias Flácidas Agudas (PFA) diante da Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII) relativa ao poliovírus.
- (40) **NOTA TÉCNICA Nº 21/2023/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA**. Atualiza medidas e diretrizes de vigilância epidemiológica da COVID-19 em portos, aeroportos e fronteiras frente a nova variante de interesse EG.5 e variante sob monitoramento BA.2.86 do SARSCOV-2.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 12 de 106

- (41) **NOTA TÉCNICA Nº 1/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA.** Manifestação técnica quanto ao alerta para dengue no Brasil.
- (42) **NOTA TÉCNICA Nº 2/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA.** Manifestação técnica sobre cenário epidemiológico de sarampo e medidas para pontos de entrada.
- (43) **Nota Técnica nº 29/2024 - DATHI/SVSA/MS.** Trata da recomendação para intensificação da vigilância de casos de mpox, frente a nova variante do clado I circulando na Região da África.
- (44) **Nota Técnica nº 14/ 2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA.** Atualização medidas de vigilância epidemiológica em Portos, Aeroportos e Fronteiras frente a intensificação da vigilância de casos de mpox, frente a nova variante do clado I circulando na Região da África.

Sobre a questão de viajante insistir em embarcar mesmo sendo identificado como caso suspeito de doença transmissível de importância para a Saúde Pública, temos legislações que defendem condutas sanitárias. Na Lei 6.259, de 30/10/1975 é colocado nos Artigos 12, 13 e 14 que a autoridade sanitária é obrigada a adotar medidas para controle de doença em decorrência de investigação epidemiológica e que os envolvidos nessa medida ficam sujeitos ao controle da autoridade sanitária.

No caso de transporte aéreo, pode-se comunicar ao comandante da aeronave que possui a prerrogativa de não autorizar o embarque.

4 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- (1) **Aeronave** - Aparelho manobrável em voo, que se sustenta e circula no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, sendo capaz de transportar pessoas, cargas e objetos.
- (2) **Aeródromo** - Área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves.
- (3) **Aeroporto** - Aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves, embarque e desembarque de pessoas, cargas e objetos.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 13 de 106

- (4) **Aeroporto Internacional** - Aeroporto designado como portão de entrada ou saída para o tráfego aéreo internacional, onde são efetuados trâmites aduaneiros, de imigração, de saúde pública, quarentena de animais e plantas e procedimentos similares.
- (5) **Afetado** - pessoas, bagagens, cargas, *containers*, meios de transporte, mercadorias, encomendas postais ou restos humanos infectados ou contaminados, ou que portem em si fonte de infecção ou contaminação, de modo a constituírem um risco à saúde pública.
- (6) **Alfândega** - é o órgão do Ministério da Fazenda/ Receita Federal responsável pela fiscalização da entrada ou saída de bens ou mercadorias nos aeroportos internacionais.
- (7) **Área de Quarentena** - área definida, onde são mantidas as vítimas em estado de observação, por determinado tempo, seguindo orientação do agente de saúde, até que sejam realizados os encaminhamentos.
- (8) **Área de Triagem** - é o local utilizado, para realização das entrevistas dos passageiros suspeitos de contaminação, para em seguida, serem encaminhados aos seus destinos, consoante orientação do agente de saúde.
- (9) **Agente biológico** - são animais, plantas e outros seres vivos incluindo bactérias, vírus, rickettsíase, parasitas, fungos, ou recombinantes, híbridos ou mutantes, inclusas as toxinas e estruturas proteicas que provocam, ou há suspeita de que possam provocar, doenças ou lesões, em graus variados, aos seres humanos ou a outros organismos.
- (10) **Agente nuclear** - é a substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), que seja composta, em parte ou completamente, por elementos nucleares, apresentado como mineral ou material nuclear, material fértil, material físsil ou material físsil especial.
- (11) **Agente químico** - é a substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), com propriedades físico-químicas que a caracterize nociva e que apresenta propriedades químicas causadoras de efeitos, permanentes ou provisórios, letais ou danosos, doenças ou lesões, em graus variados, aos seres humanos ou a outros e materiais, bem como capaz de provocar efeitos fumígenos ou incendiários.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 14 de 106

- (12) **Agente radiológico** - pode ser a fonte de radiação ou substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), que seja composta, em parte ou completamente por material radioativo, incluso o rejeito radioativo.
- (13) **Área afetada** - área geográfica para a qual foram recomendadas medidas sanitárias específicas.
- (14) **Autoridade Sanitária** - autoridade competente no âmbito da área da saúde com poderes legais para estabelecer regulamentos e executar licenciamento (habilitação) e fiscalização.
- (15) **Área Remota** - área definida pela administração aeroportuária para estacionamento de aeronaves que necessitam, dentre outros, de atendimento especial técnico ou de natureza sanitária.
- (16) **APOC** (*Airport Operations Center*) - é a dependência de onde são coordenadas todas as atividades relacionadas ao posicionamento de aeronaves no pátio, bem como as facilidades aeroportuárias e de comunicações.
- (17) **Bioproteção** (*biosecurity*) - conjunto de ações que visam a minimizar o risco do uso indevido, roubo e/ou a liberação intencional de material com potencial risco à saúde humana, animal e vegetal.
- (18) **Biossegurança** (*biosafety*) - conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam, de forma não intencional, comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente.
- (19) **Carga** - mercadoria transportada num meio de transporte ou container.
- (20) **Contaminação** - presença de uma substância ou agente tóxico ou infeccioso na superfície corporal de um ser humano ou de um animal, no interior ou na superfície de um produto preparado para consumo, ou na superfície de outro objeto inanimado, incluindo meios de transporte, que possa constituir risco à saúde pública.
- (21) **Centro de Operações de Emergência (COE)** - é o local designado de onde são coordenadas todas as ações durante o atendimento a situações de emergência.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 15 de 106

- (22) **Corpo de Bombeiros** - corporação militar do Governo Estadual, responsável pelo combate a incêndio e salvamento nas áreas urbanas e industriais, para atuar em apoio aos Bombeiros lotados na SESCINC-PA, como também efetuar combate a incêndio e salvamento no caso de acidentes aeronáuticos ocorridos fora de sua área de atuação.
- (23) **Contactante** - pessoa ou animal que teve contato com pessoa ou animal infectado, ou com ambiente contaminado, criando a oportunidade de adquirir o agente etiológico.
- (24) **Contaminação** - presença de uma substância, agente tóxico ou infeccioso na superfície corporal de um ser humano ou de um animal, no interior ou na superfície de um produto preparado para consumo, ou na superfície de outro objeto inanimado, incluindo meios de transporte, que possa constituir risco para a pública.
- (25) **Contaminação cruzada** - contaminação de uma área ou de um produto para outras áreas ou produtos, podendo essa contaminação ocorrer de forma indireta, por meio de superfícies de contato, mãos, utensílios, equipamentos e outras fontes.
- (26) **Controle sanitário** - conjunto de medidas caracterizadas por ações de fiscalização, regulamentação, educação e informação que visam prevenir ou minimizar riscos para a saúde pública.
- (27) **Descontaminação** - procedimento pelo qual são tomadas medidas de saúde para eliminar uma substância ou agente tóxico ou infeccioso presente na superfície corporal de um ser humano ou animal, no interior ou na superfície de um produto preparado para consumo, ou na superfície de outro objeto inanimado, incluindo meios de transporte, que possa constituir risco à saúde pública.
- (28) **Desinfecção** - procedimento pelo qual são tomadas medidas de saúde para controlar ou matar agentes infecciosos na superfície corporal de um ser humano ou animal, no interior ou na superfície de bagagens, cargas, *containers*, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais, mediante exposição direta a agentes químicos ou físicos.
- (29) **Defesa Biológica** - conjunto de medidas estruturadas a serem implementadas pelas Forças Armadas para prevenir e enfrentar ataques por agentes biológicos ou tóxicos.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 16 de 106

- (30) **Doença** - agravo, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para seres humanos.
- (31) **Desinsetização** - medida ou conjunto de medidas sanitárias para controle ou eliminação de insetos em todas as suas formas evolutivas, por métodos mecânicos, biológicos ou químicos.
- (32) **Doença transmissível** - doença causada por um agente infeccioso específico ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão desse agente ou de seu produto tóxico, a partir de uma pessoa ou animal infectado, ou ainda, de um reservatório para um hospedeiro suscetível, seja direta ou indiretamente intermediada por um vetor ou ambiente.
- (33) **Emergência de Saúde Pública** - evento extraordinário que pode constituir um risco para a saúde pública do estado (ou de outros) através da internacional propagação da doença, e que pode requerer uma resposta orquestrada.
- (34) **Emergência Aeroportuária** - é a situação em que o aeroporto sofre interferência parcial ou total em suas atividades normais, provocada por motivos casuais ou intencionais, requerendo providências urgentes para sanar suas consequências.
- (35) **Emergência Aeronáutica** - é a situação em que a aeronave e seus ocupantes se encontrem sob condições de perigo, latente ou iminente, decorrente de sua operação, ou tenham sofrido as consequências de acidente ou incidente aeronáutico ou, ainda estejam sob os efeitos de Ato Ilícito.
- (36) **Emergência Médica** - é caracterizada pela situação em que passageiros e/ou tripulantes, a bordo de aeronave ou em áreas do Aeroporto, venham a necessitar de socorro em decorrência de mal súbito, ou em consequência de acidentes/incidentes aeronáuticos.
- (37) **Emergência por Materiais Perigosos** (tais como: produtos radioativos, inflamáveis, corrosivos, tóxicos e outros) - é caracterizada pela situação de perigo, latente ou iminente, por contaminação ou danos a terceiros, em consequência de acidentes/incidentes aeronáuticos ou ocorrências de solo.
- (38) **ESPIN** - Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 17 de 106

- (39) **ESPII** - Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.
- (40) **Evento** - manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doenças.
- (41) **Equipamento de Proteção Individual - EPI** - dispositivo ou produto de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional ou funcional.
- (42) **Infecção** - introdução e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no interior do organismo de seres humanos ou animais que possa constituir um risco à saúde pública.
- (43) **Inspeção** - exame pela autoridade competente ou sob sua supervisão, de áreas, bagagens, cargas, *containers*, meios de transporte, instalações, mercadorias ou encomendas postais, incluindo dados e documentação relevantes, a fim de determinar se existe risco para a saúde pública.
- (44) **Isolamento** - separação de pessoas doentes ou contaminadas ou bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a propagação de infecção ou contaminação.
- (45) **Medidas Sanitárias** - procedimentos adotados para prevenir a disseminação de doença ou contaminação.
- (46) **Operador da Aeronave** - designação genérica, utilizada para se referir ao representante da Empresa Aérea envolvida em uma emergência.
- (47) **Polícia Federal (PF)** - órgão do DPF, ao qual estão afetas as seguintes atribuições, além de outras previstas em lei: revista de passageiros e bagagens de mão nos voos onde for prevista a sua execução; remoção de bomba ou objeto suspeito encontrados em aeronave ou dependência do Aeroporto; ação repressiva contra apoderadores ilícitos de aeronaves, sob coordenação do comandante do COMAR; e desenvolvimento de ações específicas de suas atribuições, quando não estiver designada a outra organização.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 18 de 106

- (48) **Polícia Militar** - corporação militar pertencente ao Governo do Estado de Porto Alegre, integrante do PLEM para auxiliar na proteção do local da emergência, bem como no controle do trânsito viário entre o Aeroporto e a rede médico-hospitalar, além de outras instruções específicas.
- (49) **Polícia Rodoviária Federal** - órgão federal para auxiliar na remoção de vítimas, bem como no controle viário entre o Aeroporto e a rede hospitalar, além das instruções específicas de sua organização.
- (50) **Polícia Civil** - órgão destinado para exercer atividades em assuntos de sua competência, como os de natureza pericial, na ocorrência de acidentes e outros previstos em lei.
- (51) **Ponto de entrada de interesse sanitário** - é uma passagem estrategicamente definida do ponto de vista epidemiológico e geográfico, considerando o fluxo de entrada e saída internacional de viajantes/ trabalhadores, meios de transporte, comércio internacional de cargas, contêineres, mercadorias, bagagens etc., bem como local onde devem estar presentes os órgãos públicos de controle (ANVISA, MAPA, Polícia Federal, Receita Federal).
- (52) **Posto de Coordenação Móvel (PCM)** - é um posto, disponibilizado em veículo próprio, no local da ocorrência, destinado a coordenar as atividades relacionadas ao atendimento à emergência.
- (53) **Quarentena** - restrição das atividades e/ou separação das pessoas suspeitas de contaminação por doenças transmissíveis, ou mesmo mercadorias e objetos possivelmente contaminados, como: bagagens, *containers*, meios de transporte, de maneira a evitar a possível propagação de infecção ou contaminação.
- (54) **Risco para a saúde pública** - probabilidade de um evento que possa afetar adversamente a saúde de populações humanas, com ênfase naqueles que possam se propagar internacionalmente, ou possa apresentar um perigo grave e direto.
- (55) **Rede médico-hospitalar** - hospitais estaduais e particulares circunvizinhos ao Aeroporto, integrantes do PLEM, que atuam através de suas equipes na prestação de primeiros socorros e remoção das vítimas de acidentes.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 19 de 106

- (56) **Seção Contraincêndio de Aeródromo (SCI)** - é o conjunto de dependências e instalações projetadas para servir de centro administrativo e operacional das atividades do SESCINC.
- (57) **Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromo Civil (SESCINC)** - é o serviço composto pelo conjunto de atividades administrativas e operacionais desenvolvidas em proveito da segurança contraincêndio do aeródromo, cuja principal finalidade é o salvamento de vidas por meio da utilização dos recursos humanos e materiais disponibilizados pelo aeródromo.
- (58) **Sala de Controle de Tráfego Aéreo (TWR)** - integrante do Sistema de Prevenção e Proteção ao voo do Comando da Aeronáutica, tendo por atribuição orientar o tráfego das aeronaves na área do Aeródromo e, durante a EMERGÊNCIA AERONÁUTICA, atuará como intermediária entre a aeronave, SESCINC e COE.
- (59) **Tripulação ou tripulantes** - pessoas a bordo de um meio de transporte que não sejam passageiros.
- (60) **Vetor** - um agente de disseminação de doenças infectocontagiosas, que pode constituir um risco para a saúde pública.
- (61) **Viajante** - pessoa física que realiza uma viagem, independente da sua condição legal ou meio de transporte; seja passageiro, tripulante, profissional não tripulante.
- (62) **Vigilância** - é a coleta, compilação e a análise contínua e sistemática de dados, para fins de saúde pública, e a disseminação oportuna de informações de saúde pública, para fins de avaliação e resposta em saúde pública, conforme necessário.

5 ABREVIATURAS

ACFT (Aircraft) - Aeronave

AIS (Aeronautical Information Service) - Serviço de Informação Aeronáutica

ALS (Approach Landing System) - Sistema de Luzes de Aproximação

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

ANV - Aeronave

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 20 de 106

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APOC - *Airport Operations Center*

ATS (Air Traffic Service) - Serviço de Tráfego Aéreo

CBM - Corpo de Bombeiros Militares

CCI - Carro Contraincêndio

CE - Comissão de Emergência

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CMES - Centro de Monitoramento Eletrônico de Segurança

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

COA - Centro de Operações Aeroportuárias

COE - Centro de Operações de Emergência

CSO - Comissão de Segurança Operacional

CVPAF - Coordenações de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos

Alfandegados

DPF - Departamento de Polícia Federal

DTCEA - Departamento de Tráfego e Controle do Espaço Aéreo

EPI - Equipamento de Proteção Individual

IML - Instituto Médico Legal

ESATA - Empresa de Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo

GGPAF - Gerência de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados

GSAER - Grupo de Segurança Aeroportuária

LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública

OACI - Organização de Aviação Civil Internacional

PAFAVIDA - Plano de assistência aos familiares das vítimas de desastre aéreo

PAPH - Posto de Atendimento Pré-hospitalar

PCM - Posto de Coordenação Móvel

PLEM - Plano de Emergência em Aeródromo

PNAVSEC - Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil

POB (People on Board) - Pessoal a Bordo

QBRN - Agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares

REA - Registro de Emergência Aeronáutica

RSI - Regulamento Sanitário Internacional

SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência

SCI - Seção Contraincêndio de Aeródromo

SESCINC - Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromo Civil

TECA - Terminal de Carga Aérea

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 21 de 106

TPS - Terminal de Passageiros

TWR - Torre de Controle

VISA - Vigilância Sanitária

6 RESPONSABILIDADES

- (1) A responsabilidade pela gestão do risco de doenças transmissíveis nos aeroportos cabe principalmente à Autoridade Sanitária local/ regional/ nacional, com relevante participação do operador do aeródromo (a orientação sobre o papel das "autoridades competentes" nos aeroportos é determinada no Regulamento Sanitário Internacional - 2005).

7 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

- (1) Os órgãos, instituições e empresas envolvidas neste plano de contingência, deverão implantar e implementar o mesmo, capacitando seus servidores e funcionários além de viabilizar a participação em seminários, reuniões e treinamentos sobre o tema.
- (2) A capacitação dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços de limpeza e higienização do aeroporto, também deve ser realizada, priorizando a biossegurança.

8 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- (1) Os órgãos e instituições envolvidos nas ações previstas neste plano são responsáveis pelo fornecimento dos EPI de seu pessoal, conforme protocolos da ANVISA, bem como pelo treinamento de seu corpo funcional quanto a utilização deles.

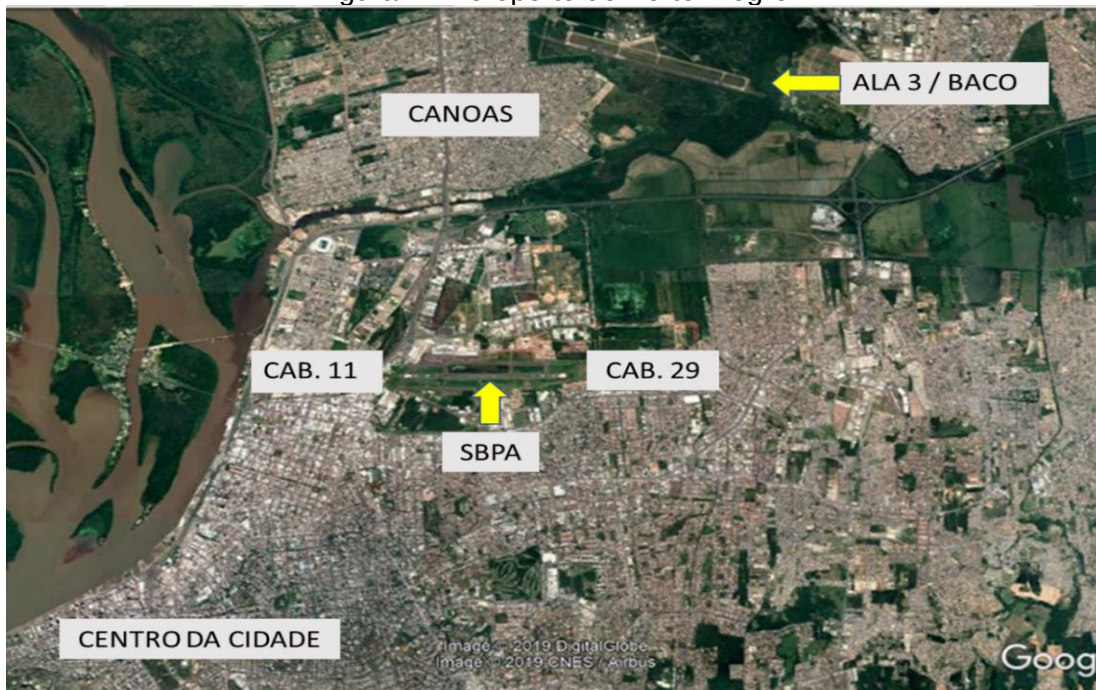
9 CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA

- (1) Segundo as definições do RSI (2005), ponto de entrada significa um local para entrada ou saída internacional de viajantes, bagagens, cargas, contêineres, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais, bem como as agências e empresas prestadoras de serviços nestes locais.
- (2) **Informações sobre o sítio aeroportuário:** Designado como de ponto entrada, o Porto Alegre Airport - possui uma área total do sítio aeroportuário de 435 hectares e, conta,

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 22 de 106

também, com um Terminal de Logística de Cargas - TECA alfandegado, com 7.088 m² de área para cargas de exportação e importação (Figura 1).

Figura 1 - Aeroporto de Porto Alegre



10 RESPOSTA OPERACIONAL

- (1) A resposta ao evento no ponto de entrada utilizará a metodologia de Sistema de Comando de Operações (SCO). Trata-se de um enfoque padronizado que responde a diferentes cenários de emergências para gestão da resposta. O SCO permite a integração das instalações, equipamentos, pessoal, procedimentos e comunicações, que operam no Ponto de Entrada de diferentes órgãos e setores dentro de uma estrutura organizativa comum. Facilita uma resposta coordenada entre as distintas jurisdições e agências funcionais, tanto públicas como privadas. Devido a sua flexibilidade, pode ser utilizado para incidentes de qualquer tipo, alcance e complexidade.
- (2) O SCO determina que em caso de ocorrência de um evento, será estabelecido um “Comandante” (líder) que definirá o plano de ação e a estrutura necessária para levar a cabo as estratégias priorizadas. O importante é descrever, para cada cenário, o que cada um dos responsáveis por essas funções deve executar. Os protocolos definirão os participantes das equipes de operações, demais funções e quem comandará.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 23 de 106

- (3) Pode ser necessário, ainda, ativar o Centro de Operações de Emergência, o COE, do município e/ou estado e/ou federal quando o evento representar risco à saúde pública, seja pela probabilidade de propagação nacional ou pela superação da capacidade de resposta local. O COE é uma estrutura que visa: direcionar os recursos, compartilhar as informações, estabelecer prioridades, proporcionar apoio legal e financeiro e atuar junto às diferentes instituições e níveis de governo.
- (4) A estrutura de Comando e Controle para resposta aos Eventos de Interesse à Saúde Pública no Aeroporto e em Aeronaves, com estrutura interinstitucional, será composta por:
- a) administração aeroportuária;
 - b) posto médico; e
 - c) autoridade de saúde local (ANVISA).

11 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

A seguir, são apresentadas as responsabilidades e atribuições de todos os órgãos envolvidos no Plano de Contingência para Eventos de Interesse à Saúde Pública, tanto em caso de Alerta de Eventos de Interesse à Saúde Pública, quanto em caso de Detecção de suspeita ou ocorrência de Evento de Interesse à Saúde Pública no Aeroporto e aeronaves.

- (1) **Responsabilidades do Posto de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados de Porto Alegre (PVPAF Porto Alegre/CVPAF-RS/ANVISA):**
- a) acompanhar os Alertas de Interesse à Saúde e medidas a serem adotadas na condução de viajantes, trabalhadores e bagagens sob suspeita;
 - b) promover a atualização deste plano conforme os novos protocolos estabelecidos frente aos diferentes cenários epidemiológicos;
 - c) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;
 - d) promover ações e atividades de promoção e prevenção à saúde, junto à comunidade aeroportuária e usuários do aeroporto, como forma de identificar perigos e minimizar riscos que possam constituir agravos;
 - e) promover, coordenar, executar e avaliar ações preventivas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, frente a um Evento de Saúde Pública;
 - f) promover a articulação intrassetorial e intersectorial necessária à execução das atividades;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 24 de 106

- g) compartilhar as informações sanitárias e epidemiológicas com os demais órgãos envolvidos;
- h) fiscalizar o controle sanitário da infraestrutura, trânsito de viajantes, trabalhadores e de produtos;
- i) fiscalizar estabelecimentos, serviços, controle de vetores e processos de interesse à saúde pública;
- j) receber as comunicações da ocorrência de evento de saúde a bordo de aeronave da Empresa Aérea e/ou da administração aeroportuária - FRAPORT;
- k) emitir Termo de Controle Sanitário de Viajante (TCSV);
- l) realizar a comunicação dos eventos aos órgãos de vigilância em saúde local, estadual e nacional;
- m) providenciar junto às companhias aéreas a lista e localização dos passageiros, possíveis contatos a bordo, escalas e conexões;
- n) realizar investigação epidemiológica, quando a for o caso;
- o) organizar a reunião de planejamento previamente a investigação de um surto ou do atendimento de um evento de interesse à saúde pública, com a participação dos órgãos envolvidos para definição de metodologia e operacionalização das atividades;
- p) orientar a administração aeroportuária - FRAPORT quanto à classificação dos resíduos oriundos do evento de saúde, quando for o caso;
- q) acompanhar a coleta de amostras ambientais;
- r) realizar a comunicação do evento, bem como informes periódicos à administração aeroportuária - FRAPORT, quando for o caso;
- s) solicitar informações adicionais aos responsáveis pela aeronave ou a administração aeroportuária, quando necessário;
- t) realizar a inspeção sanitária a bordo da aeronave, infraestrutura e determinar as medidas de controle que deverão ser adotadas tanto na aeronave quanto no aeroporto;
- u) garantir os insumos necessários aos seus servidores para a realização de suas tarefas;
- v) adotar mecanismos de divulgação de informação no âmbito do aeroporto, e;
- w) para casos de Ebola - Seguir o protocolo da ANVISA, conforme Nota Técnica 03/2014 - Prevenção e Controle de Ebola em Pontos de Entrada.
- x) desenvolve ações para o controle sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos; o controle de pragas e vetores; a orientação e o controle sanitário de viajantes; o controle sanitário da qualidade da água, dos produtos e serviços ofertados; e na colaboração para a elaboração de planos de contingência para situações de emergência e de risco para a saúde pública;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 25 de 106

- y) as medidas de saúde pública em aeroportos (pontos de entrada) podem ocorrer a partir de evento de saúde a bordo de aeronave, no terminal de passageiros ou em suas áreas, já que além dos viajantes, a comunidade aeroportuária pode ser acometida;
- z) todas estas ações estão alinhadas com a missão da ANVISA de: “Promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada com os estados, os municípios e o Distrito Federal, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira”.

(2) Responsabilidades do Posto Aeroportuário da VIGIAGRO/MAPA:

- a) acompanhar os Alertas de Interesse à Saúde e medidas a serem adotadas na condução de passageiros e bagagens sob suspeita;
- b) promover a atualização dos planos específicos para o aeroporto conforme os novos protocolos estabelecidos frente aos diferentes cenários epidemiológicos;
- c) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;
- d) promover ações e atividades educativo-sanitários (embasado na Instrução Normativa nº 28/2008, sobre educação sanitária), junto à comunidade aeroportuária e usuários do aeroporto, como forma de minimizar riscos epidemiológicos;
- e) promover, coordenar, executar e avaliar ações de defesa sanitária animal no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), frente a um Evento de Saúde Pública relacionado a produtos de origem animal;
- f) executar análises laboratoriais requeridas da área animal;
- g) promover a articulação intrassetorial e intersectorial necessária à execução das atividades;
- h) compartilhar as informações epidemiológicas com os demais órgãos envolvidos;
- i) subsidiar a Fraport Brasil - Porto Alegre e ANAC tecnicamente com as informações necessárias;
- j) fiscalizar o controle de trânsito de animais e de produtos em Vigilância Agropecuária Internacional;
- k) capacitar recursos humanos e colaboradores;
- l) disponibilizar EPI a seus servidores e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção.

(3) Responsabilidades da Administração Aeroportuária:

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 26 de 106

- a) dar cumprimento aos dispositivos legais e demais recomendações técnicas no que diz respeito ao item 2 – Objetivo, deste documento;
- b) divulgar à comunidade aeroportuária os informes recebidos;
- c) divulgar às empresas aéreas ESATAS e empresa terceirizada de limpeza e desinfecção as medidas a serem adotadas na condução de passageiros e bagagens sob suspeita.
- d) em caso de suspeita ou ocorrência de ESP, comunicar imediatamente à ANVISA e PPS, e comunicar demais órgãos envolvidos (PF, RF, ANAC, MAPA), conforme fluxo estabelecido;
- e) quando da suspeita ou ocorrência de evento de interesse de saúde pública a bordo da aeronave, comunicar à autoridade sanitária e o posto médico, imediatamente;
- f) definir, juntamente com a ANAC e as Operadoras de Aeronaves, as operações aeroportuárias, propondo medidas de adequação, principalmente no que se refere a utilização de instalações de terminais, interdição de posições de aeronaves, e alterações de posições de aeronaves;
- g) providenciar a capacitação da Equipe de Saúde (Serviço Médico de Emergência) da Administração Aeroportuária Local, seguindo orientações do MS e da ANVISA;
- h) designar um representante do aeroporto como responsável pelas ações e informação e articulação com os demais órgãos;
- i) atualizar e divulgar ao Posto aeroportuário da ANVISA a relação da equipe médica disponível no aeroporto;
- j) definir, segundo critérios operacionais, o pessoal imprescindível para garantir a continuidade da operação do aeroporto;
- k) disponibilizar EPI a seus funcionários e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção;
- l) garantir os espaços físicos disponíveis para segregação de viajantes, destinado à adoção de medidas de controle sanitário dos tripulantes e passageiros;
- m) disponibilizar ambulância para a remoção às unidades de atendimento de referência;
- n) informar à ANAC a ocorrência de interdição, total ou parcial de terminais e do aeroporto, se for o caso;
- o) definir e informar as áreas específicas e terminal de esteiras para a descarga das bagagens oriundas de voos classificados como de risco sanitário, agropecuário ou ambiental;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 27 de 106

- p) garantir as etapas do processo de gestão, estabelecidos pela ANVISA e Secretarias de Saúde, no atendimento aos casos suspeitos de Eventos de Interesse à Saúde Pública conforme consta no Anexo V.

(4) Responsabilidades da ANAC:

- a) divulgar às empresas aéreas e ESATAS os informes recebidos. Poderá divulgar aos representantes das empresas com base no SBPA através das reuniões CSO e CCA;
- b) orientar as empresas aéreas e ESATAS as medidas a serem adotadas na condução de passageiros e bagagens sob suspeita. Fraport Brasil - Porto Alegre poderá divulgar aos representantes das empresas com base no SBPA através das reuniões CSO e CCA.
- c) supervisionar e fiscalizar as empresas aéreas e ESATAS;
- d) em caso de interdição total ou parcial do aeroporto, acionar as empresas aéreas;
- e) Definir, juntamente com a Administração Aeroportuária Local e as Operadoras de Aeronaves, as operações aeroportuárias, propondo medidas de adequação, principalmente no que se refere a utilização de instalações de terminais, interdição de posições de aeronaves, e alterações de posições de aeronaves.

(5) Responsabilidades das empresas aéreas (inclui as empresas de taxi aéreo e da aviação geral):

- a) Atender as orientações e adoção de medidas preventivas recomendadas, em caso de ocorrência de eventos ou detecção de suspeitas;
- b) Informar a Administração Aeroportuária Local da ocorrência do evento, o número de passageiros a bordo, no menor tempo possível, após a detecção da suspeita;
- c) Capacitar os funcionários quanto aos procedimentos necessários, para atendimento a eventos de interesse à saúde pública em voos, de acordo com os protocolos e demais orientações da ANVISA/MS, SES, SMS e UVAGRO;
- d) Disponibilizar EPI aos seus funcionários envolvidos na ocorrência, fazer cumprir a sua utilização e descartá-los com as orientações pertinentes ao evento.

(6) Responsabilidades das empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo (ESATAS) e empresas terceirizadas de limpeza e desinfecção e gerenciamento de resíduos sólidos:

- a) capacitar os funcionários quanto aos procedimentos necessários, para atendimento a eventos de interesse à saúde pública em voos, de acordo com os protocolos e demais orientações da ANVISA/MS, e UVAGRO;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 28 de 106

- b) disponibilizar EPI a seus servidores e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção;
- c) garantir a correta execução das etapas do processo de gestão e manutenção dos protocolos, no atendimento aos casos suspeitos de Eventos de Interesse à Saúde Pública.

(7) Responsabilidades da Secretaria Estadual de Saúde - SES:

- a) definir, acompanhar e divulgar os Alertas de Interesse à Saúde Pública emitidos pelos comitês CIEVS (MS, SES, SMS);
- b) apoiar a ANVISA quanto a definição de caso suspeito ou confirmado e avaliação de risco;
- c) notificar ocorrência ou suspeita de ocorrência de eventos, de acordo com o fluxo estabelecido;
- d) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;
- e) disponibilizar EPI a seus servidores e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção;
- f) proceder a investigação epidemiológica, coordenando a execução de atividades de campo, sempre que necessário e quando solicitada pelos demais níveis de gestão do SUS;
- g) realizar a coleta, acondicionamento e transporte de amostras, com o apoio da VISA municipal e LACEN;
- h) definir os hospitais de referência para atender aos ESP, conforme o Plano Estadual ou outra definição.

(8) Responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS:

- a) definir, acompanhar e divulgar os Alertas de Interesse à Saúde Pública emitidos pelos comitês CIEVS (MS, SES, SMS);
- b) apoiar a ANVISA quanto a definição de caso suspeito ou confirmado e avaliação de risco;
- c) notificar ocorrência ou suspeita de ocorrência de eventos, de acordo com o fluxo estabelecido;
- d) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 29 de 106

- e) disponibilizar EPI a seus servidores e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção;
- f) proceder a investigação epidemiológica, se necessário;
- g) realizar a coleta, acondicionamento e transporte de amostras, com o apoio da VISA municipal e LACEN.

(9) Responsabilidades do Posto de Primeiros Socorros do Aeroporto - PPS:

- a) o Porto Alegre *Airport* conta com um Serviço Médico de Emergência (SME), que dispõe de equipes de plantão para o funcionamento do Serviço de Atendimento Médico de Emergência do aeroporto para o emprego imediato durante 24h.
- b) trata-se de equipes formadas por um médico, um enfermeiro (a) e um motorista apoiados por uma ambulância tipo UTI e uma ambulância básica, além de toda aparelhagem e infraestrutura para este fim.
- c) em alguns eventos previstos neste plano, a equipe do SME, atuará apenas como apoio, a depender da dimensão da emergência, que deverá ser atendida pelos órgãos e instituições competentes.
- d) dar cumprimento e apoio as normas e orientações direcionadas ao serviço de atendimento do PPS;
- e) acompanhar os Alertas de Interesse à Saúde Pública emitidos pelos comitês CIEVS (MS, SES, SMS).
- f) atender viajantes ou trabalhadores suspeitos e sintomáticos de evento de saúde pública, a bordo de aeronave ou em solo, bem como na área reservada para o atendimento de emergências.
- g) comunicar imediatamente o posto aeroportuário da ANVISA e a Administração Aeroportuária Local quando ocorrer atendimento de suspeito de doenças sob vigilância epidemiológica, infectocontagiosa e com potencial risco de disseminação.
- h) notificar eventos relacionados na lista de Notificação Compulsória do Ministério da Saúde.
- i) disponibilizar EPI e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção.
- j) acompanhar o transporte dos passageiros atendidos na ambulância do PPS, caso seja necessário.
- k) manter a autoridade sanitária aeroportuária atualizada quanto à equipe médica, nome do responsável, como acioná-la e período de funcionamento: Todo acionamento deverá ser centralizado via COE - Centro de Operações de Emergência.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 30 de 106

(10) **Responsabilidades do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU:**

- a) Caso seja acionado, agir conforme preconizam os seus respectivos protocolos internos sempre em coordenação com o médico de plantão no aeroporto, viabilizando a seu critério o encaminhamento de ambulâncias extras ao aeroporto e a respectiva regulação de pacientes.

(11) **Responsabilidades da Polícia Federal:**

- a) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;
- b) adotar fluxo de imigração pré-estabelecido, na área reservada para o Centro de Atendimento a Emergências, nos voos internacionais com suspeita de evento de saúde pública, conforme orientações da Autoridade Sanitária local;
- c) disponibilizar EPI e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção.

(12) **Responsabilidades da Defesa Civil Municipal e/ou Casa Militar:**

- a) adotar as medidas previstas em suas instruções para a eventualidade;
- b) disponibilizar EPI e fazer cumprir a sua utilização sempre que necessário, bem como identificar e divulgar o local de guarda dos mesmos e garantir sua manutenção.

(13) **Responsabilidades da Vigilância em Saúde em pontos de entrada:**

- a) de acordo com a Lei nº 8.080/90, no Art. 2º, inciso IV da Lei nº 9.782/99, reafirmado no Regimento Interno da ANVISA, Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006 (republicada no DOU de 21.08.06 e retificada no DOU de 29.08.06), Anexo I, Art. 1º e 2º, a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras é competência da União, podendo de forma suplementar ser exercida pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Neste âmbito, cabe a Gerência de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados - GGPAF, a coordenação e execução de ações que garantam a segurança sanitária em tais áreas, por meio das Coordenações de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados - CVPAF (s), instaladas nas 27 Unidades Federadas do país.

11.1 HOSPITAL DE REFERÊNCIA

- (1) O Hospital de referência para o acolhimento e tratamento de casos que envolvam emergência de saúde pública, identificados no Porto Alegre *Airport* será definido, em

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 31 de 106

caso de necessidade, pela autoridade sanitária (ANVISA) em coordenação com os órgãos de vigilância municipal e estadual.

11.2 MEIOS DE ACIONAMENTO

- (1) Em caso de ocorrências de emergências de saúde pública de interesse internacional, o APOC (*Airport Operations Center*) comunicará a ANVISA imediatamente e acionará o Centro de Operações de Emergência - COE o qual utilizará os meios descritos neste plano para realização dos acionamentos (Anexos I e II). As comunicações seguirão de acordo com fluxograma de acionamento Anexo II.

11.3 PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

11.3.1 Atribuição

- (1) A emergência de saúde pública é caracterizada por um evento extraordinário que pode constituir um risco para a saúde pública do Estado (ou de outros) através da propagação internacional da doença, e que requer uma resposta coordenada.
- (2) **O operador da TWR-PA deverá (aeronave Voo):**
 - a) acionar o APOC. Porém nos casos de Ebola - seguiremos o protocolo da ANVISA, conforme Nota Técnica 03/2014 - Prevenção e Controle de Ebola em Pontos de Entrada.
- (3) **O representante da empresa aérea ou do operador da aeronave deverá:**
 - a) notificar o evento de saúde ao Posto da ANVISA no Aeroporto através da Declaração Geral da Aeronave - parte de saúde;
 - b) acompanhar o atendimento, de forma a dar assistência ao passageiro ou tripulante no que lhe competir;
 - c) possibilitar o ingresso das equipes de saúde ao interior da aeronave;
 - d) deslocar a aeronave para local designado pela Autoridade Sanitária;
 - e) disponibilizar EPI para uso de seu efetivo envolvido com os casos;
 - f) fazer cumprir o uso de EPI para as operações de limpeza, desinfecção e descontaminação de aeronave;
 - g) promover a limpeza, desinfecção e descontaminação de aeronave;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 32 de 106

- h) adotar as providências previstas em seus planos de assistência aos familiares das vítimas de desastre aéreo (PAFAVIDA);
- i) acompanhar o passageiro e/ou tripulante nas remoções à Unidade Médica Hospitalar quando for o caso;
- j) quando solicitado pela ANVISA, encaminhar os passageiros e tripulação desembarcados para a Área de Atendimento de Emergência do aeroporto;
- k) quando solicitado pela ANVISA, fornece a lista e localização dos assentos dos passageiros, possíveis contatos a bordo, escalas e conexões;
- l) adotar as medidas previstas em suas instruções, 2;
- m) para casos de Ebola - Seguir o protocolo da ANVISA, conforme Nota Técnica 03/2014 - Prevenção e Controle de Ebola em Pontos de Entrada.

(4) Empresas auxiliares de transporte aéreo (ESATAS) deverão:

- a) proceder de acordo com o item das Empresas Aéreas quando exercer a atividade de operadores de aeronave;
- b) manter procedimento operacional padronizado para limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves de acordo com a legislação sanitária vigente;
- c) manter reserva de produtos saneantes, materiais, equipamentos e EPIs para limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves de acordo com a legislação sanitária vigente;
- d) manter pessoal treinado para executar os procedimentos de limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves de acordo com a legislação sanitária vigente;
- e) realizar a limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves quando acionadas para tal ação, e;
- f) para casos de Ebola - Seguir o protocolo da ANVISA, conforme Nota Técnica 03/2014 - Prevenção e Controle de Ebola em Pontos de Entrada.

(5) Outros integrantes deverão:

- a) quando acionados, atuar em conformidade com suas instruções específicas para o evento; e se inteirar da situação junto ao Agente de Plantão da ANVISA e Oficial de turno da FRAPORT.

11.4 ATENDIMENTO AOS FAMILIARES DOS PASSAGEIROS

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 33 de 106

- (1) A Administração aeroportuária deverá disponibilizar salas exclusiva para atendimento de familiares dos passageiros do voo de chegada ou partida do Aeroporto, conforme consta no Plano de Emergência Aeroportuário em sua versão vigente.
- (2) O operador da aeronave deve dispor de pessoal para auxiliar no atendimento dos familiares dos passageiros e imprensa conforme prevê os seus PAFAVIDA.

11.5 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁREAS

- (1) Os procedimentos para realização de limpeza e desinfecção de áreas afetadas ou suspeitas deverão ser realizados em consonância com o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada- RDC/ ANVISA nº 2, de 8 de janeiro de 2003 (Anexo VI).

11.6 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL INFECTANTE/INFECTADO)

- (1) O tratamento dos resíduos sólidos deverá atender o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados; e será realizado de acordo com os procedimentos descritos no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, do Aeroporto Internacional de Porto Alegre;
- (2) Cabe salientar que num caso de emergência de saúde pública em aeronave, todo o resíduo sólido de bordo e EPIs utilizados deverão ser gerenciados e tratados como resíduo potencialmente infectante (Grupo A, de acordo com a Resolução RDC nº 56/2008), tendo seus procedimentos de acondicionamento, coleta e destinação final descritos no PGRS do SBPA.

12 CÓDIGOS OU FASES DE ALERTAS FORMAIS

- (1) Orienta-se a definir os níveis ativação das estruturas organizacionais. O Ministério da Saúde propôs os seguintes níveis:
 - a) **Nível 0** - a ameaça não é importante para a saúde pública, porém exige o manejo clínico local;
 - b) **Nível 1** - a ameaça é importante, mas o sistema local de saúde pode responder com os recursos de emergência disponíveis permanentemente, a atividade federal é de monitoramento e pode exigir a ativação do RSI;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 34 de 106

- c) **Nível 2** - a ameaça é importante e o sistema local de saúde exige uma mobilização de mais recursos locais ou de apoio do nível estadual e talvez alguns recursos federais (por exemplo, uma equipe de investigação epidemiológica) e pode exigir a ativação do RSI;
 - d) **Nível 3** - a ameaça é significativa e múltiplas jurisdições são afetadas, os níveis estaduais e municipais exigem recursos federais (humano, físico ou financeiro), este nível de emergência exige a ativação do RSI;
 - e) **Nível 4** - a ameaça é importante, o maior impacto sobre os diferentes níveis exige uma resposta ampla do governo, este evento constitui uma crise.
- (2) Em estado de normalidade, o Ponto de Entrada (aeroporto) se encontra sempre no Nível de Alerta 0 (zero). Cabe ao Posto da ANVISA no aeroporto comunicar à administração aeroportuária qualquer mudança no nível de alerta, assim como a necessidade de emprego dos recursos disponíveis neste Plano.

12.1 AVALIAÇÃO DE RISCO

- (1) Toda suspeita de evento a bordo ou em solo deve ser comunicado à Autoridade Sanitária, conforme protocolos 01, 03, 05, 07, 08 e 09.
- (2) Mediante a informação recebida, cabe à autoridade sanitária avaliar o risco de acordo com o tipo de evento (indivíduo ou ambiente), considerando minimamente:
 - a) natureza do evento;
 - b) sinais, sintomas, data de início dos mesmos e medicamentos utilizados;
 - c) cenário epidemiológico, fluxo migratório do indivíduo (procedência, incluindo suas escalas, conexões) e alerta sanitário/epidemiológico/ambiental.
- (3) Caso o evento represente risco para a Saúde Pública, a Autoridade Sanitária ativa o Plano de Contingência para Emergência em Saúde Pública (PCESP) (utiliza o plano/protocolo definido pelo MS, se houver).
- (4) Havendo declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ou Internacional a Autoridade Sanitária local ativa PCESP e segue as orientações específicas emitidas pelas Autoridades de Saúde Nacional.

12.2 EVENTO COM INDIVÍDUO

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 35 de 106

(1) **A bordo** Protocolo 01 - ANEXO V:

- a) orientar para o estacionamento/atracação do meio de transporte em local estratégico previamente definido;
- b) ativar local para triagem previamente definido;
- c) ativar a sala de crise.

(2) **Em solo** Protocolo 02 - ANEXO V:

- a) isolar a área;
- b) avaliar o local para o atendimento do caso suspeito;
- c) ativar a sala de crise.

12.3 EVENTOS AMBIENTAIS

(1) Evento por agente químico, biológico, radiológico ou nuclear - QBRN:

- a) isolar a área e comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros;
- b) área de Saúde e Segurança do Trabalho da FRAPORT deve ser acionada - **(51) 99882-2209**;
- c) caso o Corpo de Bombeiros detecte radiação, acionar a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN Horário ADM (51) 3308-6942 / Emergência **H24: (21) 99769 7313 / (21) 99872 4624**;
- d) caso seja agente químico o próprio Corpo de Bombeiros segue com a resposta;
- e) a equipe da ANVISA deve atuar apenas na zona fria;
- f) comunicar ao Ministério da Saúde;
- g) comunicar à Polícia Federal para seguir com os tramites legais.

(2) Evento por vetor/reservatório:

- a) identificar a natureza do vetor/reservatório e local da ocorrência;
- b) classificar o nível de risco potencial, considerando a presença e quantidade de vetor/reservatório; o número de pessoas expostas e provável agente infeccioso

12.4 ATIVAÇÃO DO PLANO

(1) O plano será ativado em caso de:

- a) avaliação de risco pela Autoridade Sanitária local mediante a comunicação de caso suspeito de evento de importância para a Saúde Pública;
- b) em um cenário de Emergência em Saúde Pública - ESP com alerta do Ministério da Saúde.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 36 de 106

12.5 DESATIVAÇÃO DO PLANO

- (1) O plano será desativado em caso de:
 - a) avaliação pela Autoridade Sanitária local descartando a suspeita de ESP;
 - b) declaração do Ministério da Saúde de encerramento da ESP.

13 DISPOSIÇÕES FINAIS

- (1) As ações previstas neste plano contemplam as ações iniciais na área do aeroporto, sendo sua continuidade prevista nos normativos da Autoridade Sanitária e demais Órgãos competentes.
- (2) Observar os procedimentos estabelecidos no Plano de Emergência do Porto Alegre *Airport* no que couber.
- (3) Plano de Atendimento à Emergência de Saúde Pública do Porto Alegre *Airport* deve ser revisado sempre que houver necessidade operacional ou de adequação, motivado pela Autoridade Sanitária ou pela Administração do Aeroporto. A ANVISA organizará anualmente um simulado de mesa.
- (4) As instituições envolvidas comprometem-se ao fiel cumprimento dos pontos acordados e a comunicar aos demais parceiros quaisquer alteração dos mecanismos de notificação constantes do anexo.
- (5) Operação da Prefeitura de Porto Alegre: Com o objetivo de identificar e monitorar passageiros que ingressam em Porto Alegre eventualmente contaminados com Variante de Preocupação (VOC) do vírus Sars-Cov-2 (B.1.617) e outras VOCs, e minimizar o impacto da entrada de novas VOCs no município, que possam elevar os índices de contágio e/ou colapsar o sistema de saúde, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre em conjunto com a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul realizou um controle sanitário no Aeroporto Internacional Salgado Filho por 14 dias, entre os dias 14/06/2021 a 27/06/2021.
- (6) Os passageiros eram convidados a realizar o teste rápido para SARS-CoV-2 no desembarque doméstico do TPS, onde foi fornecido o espaço físico pela Fraport. O fluxo de comunicação e notificação de testagem caso ocorresse a detecção de casos pós testagem encontra-se no Anexo IX.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 37 de 106

- (7) O ofício com orientações sobre a barreira sanitária recebido pela Prefeitura de Porto Alegre encontra-se no Anexo XII. Os procedimentos e resultados da "Ação de Controle Sanitário e Rastreamento de Variantes do SARS-Cov-2 no Aeroporto Internacional Salgado Filho", da Prefeitura de Porto Alegre encontram-se no Anexo XIII.

14 RELAÇÃO DE ANEXOS

O Quadro 1 abaixo ilustra a Relação de anexos pertencentes ao documento.

Quadro 1 - Relação dos Anexos

Anexos	Descrição
Anexo I	Relação de Contatos.
Anexo II	Fluxogramas de Acionamentos.
Anexo III	Mapa de Grade Interno do Aeroporto.
Anexo IV	Croqui das Áreas de Triagem e Isolamento de Passageiros.
Anexo V	Protocolo Operacional Padrão.
Anexo VI	Procedimento: Limpeza e Desinfecção de Ambientes, Equipamentos, Utensílios Potencialmente Contaminados, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários.
Anexo VII	Procedimentos para Ações a Serem Realizadas Conforme os Critérios da OMS
Anexo VIII	Fluxo de Testagem em Aeroportos
Anexo IX	Ficha PLEM
Anexo X	Ofício da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria Municipal de Saúde com Orientações para a Barreira Sanitária
Anexo XI	Ação de Controle Sanitário e Rastreamento de Variantes do Sars-Cov-2 no Aeroporto Internacional Salgado Filho – Procedimentos e Resultados
Anexo XII	Nota Técnica Sobre A Variante Delta
Anexo XIII	Reunião de Alinhamento Anvisa/SMS/ Fraport - Controle Sanitário Aeroporto POA
Anexo XIV	Ofício-Circular nº. 02/2022 - ANVISA - Procedimentos em caso de contaminação pelo vírus Monkeypox
Anexo XV	Ofício-Circular nº. 15/2024 - ANVISA - Encaminha a Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA - Atualização de medidas em pontos de entrada frente à vigilância de casos de mpox na Região da África.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 38 de 106

ANEXO I - Relação de Contatos

Para realizar ligações externas dos ramais Fraport, colocar o número zero (0 + o número desejado).

FRAPORT	
Oficial de Turno Fraport <i>Duty Officer</i>	(51) 99564-4320
Fabricio Cardoso Gestor do Aeródromo/Operações	(51) 9 9888-9739 f.cardoso@fraport-brasil.com
Wagner Alberto Pereira Costa Gerente Operações Airside	(51) 9 9894-5756 w.costa@fraport-brasil.com
Carlos Schmid Gonçalves Diretor de Emergência e Segurança	(85) 9 8124-7975 / (85) 3392-1551 c.schmid@fraport-brasil.com
Roberto P. Silva Junior Gerente de Resposta à Emergência	(85) 9 8172-2866 / (85) 3392-1017 r.pereira@fraport-brasil.com
Gustavo Catelli Vieira da Silva Coord. Resposta e Emergência	(51) 3358-2729 / (51) 9 9954-7031 g.vsilva@fraport-brasil.com
José Carlos Saraiva Coord. Segurança Operacional	(51) 3358-2008 / (51) 9 9584-1623 j.saraiva@fraport-brasil.com
André Galego Gerente de Segurança Avsec	(51) 9 9778-0769 a.galego@fraport-brasil.com
Cássio Gonçalves Diretor de Infraestrutura e Manutenção	(51) 3358-2122 / (51) 9 8021-3963 c.goncalves@fraport-brasil.com
Matheus de Oliveira Vasconcellos Gerente de Operações Terminal	(51) 9 9617-9083 m.vasconcellos@fraport-brasil.com

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 39 de 106

Tatiane Penninck Martins Coordenadora APOC	(51) 9 8019-3436 t.martins@fraport-brasil.com
---	--

ÓRGÃOS PÚBLICOS	
Bombeiro Militar	193 / (51) 98577-2436 Destacamento Floresta
ANAC - Unidade Regional Sul	163 (Plantão)
Polícia Federal	Aeroporto: (51) 3358-2295 Delegado Eduardo Brun Souza (54) 9 9910-9828 (51) 3358-2925 (51) 9 9466-1598
VIGIAGRO - Ministério da Agricultura	(51) 3358-2275 (51) 3358 – 1143 / (51) 3358- 1153 uvagro-aeroporto-rs@agro.gov.br Lucia
DIEME - Divisão de Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares (Órgão Federal)	(21) 2442-8539 / (21) 2442-8521
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)	0800-721-2333
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	199 / (51) 3289-0199
Departamento Médico Legal (DML)	(51) 3288-5150
Receita Federal	(51) 3358-2864 (Recepção – 24h) / (51) 3358- 2850 / (51) 3358-2851 (51) 3358-2841(TECA) / (51) 3358-2860 (Chefe Erno) (51) 3358-2091 (Secretária)

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 40 de 106

	savig.rs.irfpoa@rfb.gov.br
Empresa Pública de Transporte e Circulação - (EPTC)	156 / (51) 3289-4218 / (51) 9 9305-7608 (Coordenador Wagner Cruz) (51) 3289-4200 (plantão 24h) / (51) 3289-4273 (51) 3289-4494 / (51) 3289-4495 (51) 3289-4404 (51) 3289-4224
ANVISA	(51) 3358-2084 / (51) 3358-3583 / (51) 98113-1304 (Fiscalização)
Polícia Civil	(51) 9 8585-9984 (Plantão) Delegado Juliano Brasil Ferreira (Responsável)
Batalhão de Aviação da Brigada Militar	(51) 9 8501-6552 (H24) procurar pelo Oficial do Turno pelo Batalhão
Polícia Rodoviária Federal	Chefe PRF (Mendonça) (51) 99292-0384 / (51) 99982-4520
Brigada Militar	190
DTCEA-CO - Torre de Controle	(51) 99917-4192 Tenente Marqueti (51) 3371-4018 / (51) 3371-3539
CENIPA (Av.Regular)	Oficial de Sobreaviso: (61) 99994-9554 Recepção: (61) 3364-8800
SERIPA 5 (Av.Geral)	Oficial de Sobreaviso: (51) 99268-3043 Auxiliar de Sobreaviso: (51) 99283-5207 Chefia do SERIPA 5: (51) 3462-1104

EMPRESAS AÉREAS

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 41 de 106

AEROLÍNEAS ARGENTINAS	(51) 9 8128-2800 alejandro.poveda@aerolineas.com.ar Alejandro Poveda (Gerente) (51) 9 9631-2821 / (51) 3221-2358 diego.brasil@aerolineas.com.ar Diego Brasil Amaro (Supervisor)
AZUL LINHAS AÉREAS / AZUL CONECTA	(51) 9 8511-0666 fabiano.machado@voeazul.com.br Fabiano Machado (Gerente Base Poa) (11) 99643-3954 – MOD (Gerente de Turno CCO) (21) 98556-4424 – Coordenador Suporte Operacional da Azul no CGNA (19) 98603-0212 – Analista de Segurança da Infraestrutura Aeroportuária Dias não úteis – MOD (Gerente de Turno do CCO) – (11) 99643-3954
GOL	(51) 3358-2028 – Checkout (51) 9 8923-2442 – Gerência apbatimanza@voegol.com.br Ana Batimanza (Preposta Base Poa) (11) 94983-3724 – Gerente de <i>Safety</i> (11) 99462-1738 – Gerente de Infraestrutura (13) 98148-7427 – Analista de Infraestrutura (11) 97058-4374 – Gerente de CCO Dias não úteis – Piloto de Apoio Operacional – (11) 99496-4932
LATAM	(51) 3358-2039 / (27) 9 9903-5830 Higor.fernandes01@latam.com Higor Oscar Fernandes (Coordenador Base Poa) (11) 98792-5222 – Plantão <i>Safety</i> (12) 99128-4826 – Coordenação <i>Safety</i> (11) 97522-5006 – Analista de Infraestrutura

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 42 de 106

	Dias não úteis – Plantão <i>Safety</i> – (11) 98792-5222
VOEPASS	(47) 9 9775-0128 poa.katias@voepass.com.br Katia Santos (Gerente Base Poa)

HANGARES - AVIAÇÃO GERAL	
AEROJET	(51) 9 9192-3322 Waldemar (Responsável) (51) 3361-3990 Ivan (Supervisor) (51) 9 8933-8635
AEROMOT	(51) 9 8265-0059 / (51) 3357-8500 Cristiane (Responsável)
BRIGADA MILITAR	(51) 9 8455-8880 / (51) 9 8526-7997 Major Budel (Responsável) (51) 98501-6552 (Chefe de plantão) (51) 99228-5415 (Tenente Coronel Reis Reis – Chefe de logística)
UNIAIR	(51) 2121-1158 (51) 2121-1100 0800 519 519 0 (Plantão) Juliane (Responsável) (51) 2121-1146 Marcelo (Gerente Manutenção) (51) 99668-8590
POLÍCIA CIVIL	(51) 3343-6329 / (51) 9 8445-4739 / (51) 9 8401-5745 Delegado Carlos Iglesias (Responsável)

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 43 de 106

GRENDENE	Reginaldo (51) 9 9245-6116
-----------------	----------------------------

EMPRESAS DE SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AÉREO	
ORBITAL	(51) 3358-2291 Ricardo Botelho (Gerente Regional) (21) 9 8830-6635 / (21) 3398-5896 Luis Freitas (Supervisor) (51) 9 9623-1092
PROAIR	(51) 3358 2057 / (51) 9 8237-2793 gabriel.carecho@protege.com.br Gabriel Carecho (Responsável)
RP ATIVIDADES AUXILIARES	(51) 9 9663-9644/ (44) 9 9849-5544 poa.toni@rpaata.com.br Toni Alves (Responsável) Alexandre Pereira Andrade (Gerente Operacional) (51) 9 9389-8811 / (44) 9 9949-5455 poa.alexandre@rpaata.com.br
DNATA	Everton Hiemer (Gerente operacional) (51) 98272-6043

ABASTECEDORAS	
VIBRA ENERGIA / CONTRATANTE DA MARLIM	(51) 3375-9102 / (51) 9 9799-5526 Rafael (Analista) rsinkler@vibraenergia.com.br
MARLIM AVIATION	(51) 3371-3131

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 44 de 106

	Bradle (Supervisor) bradle.mendes@marlimaviation.com.br Carlos Eduardo (Supervisor) cet@marlimaviation.com.br (51) 991180669
RAIZEN	(51) 99234-5234 / (51) 3455-7512 gabriel.l.sousa@raizen.com Gabriel Lucio de Sousa (Responsável) Josias Moraes (supervisor) (51) 999191488

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR	
Serviço Médico de Emergência	(51) 3358-2239 Contato direto com APOC para acionamentos
SAMU	192 (51) 9 9935-7874 - Dr. Fabiano SAMU Porto Alegre* Telefones de contingência SAMU Municipal de Porto Alegre*: (51) 3289 - 2509 (51) 3289 – 2510 Telefones de contingência SAMU Estadual (CANOAS)*: (51) 3320-0192 (51) 3320-0100 *Utilizar somente em caso de falha com o 192
NOTA: O SAMU É QUEM IRÁ ACIONAR E REGULAR AS VAGAS DOS HOSPITAIS	
Hospital da Aeronáutica de Canoas (HACO) R. Guilherme Shell, 3950 – Canoas	Emergência (51) 3462-1149 / (51) 3462-1115 V COMAR R: 1564

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 45 de 106

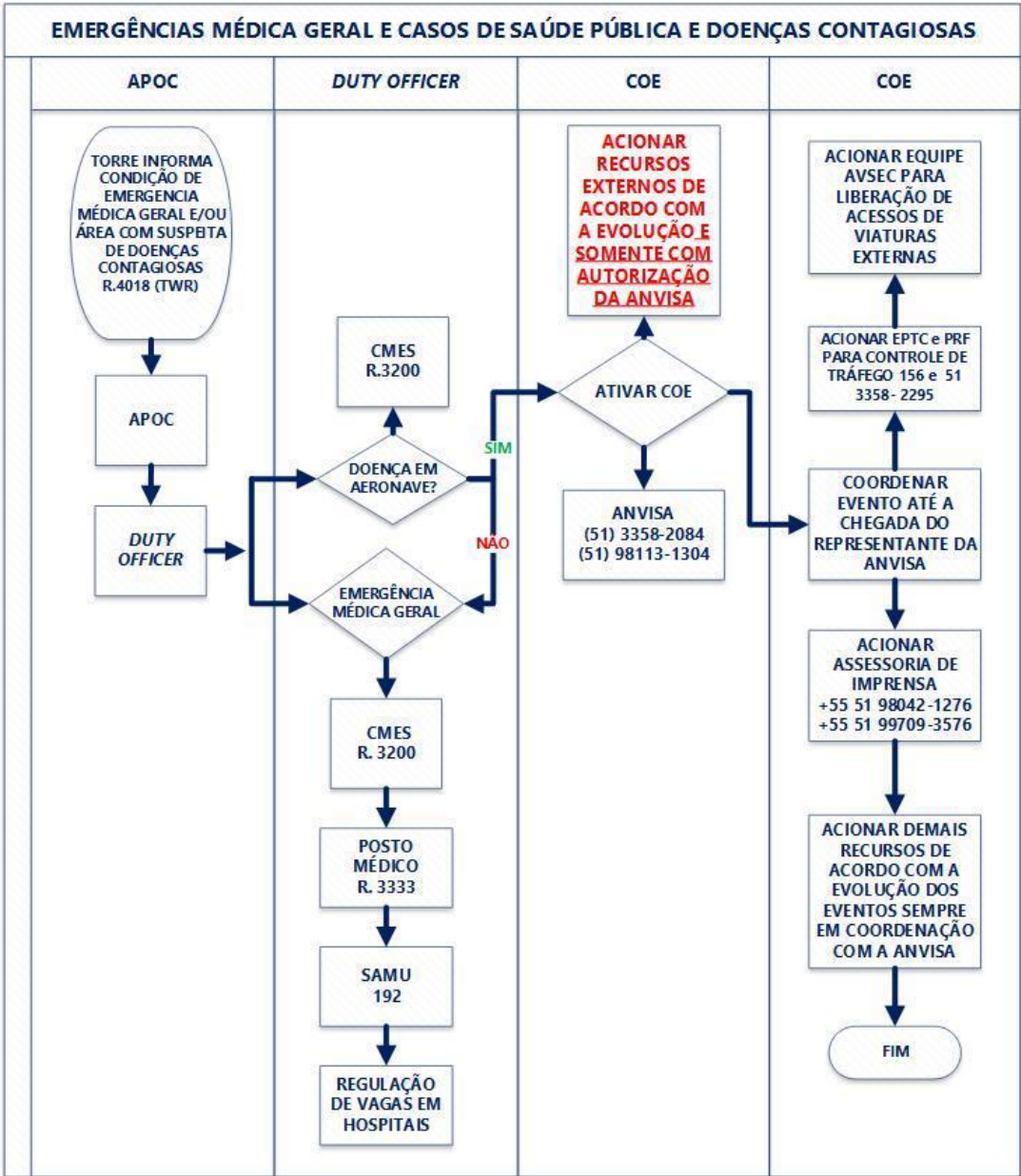
Hospital Cristo Redentor Rua Domingos Rubbo, 20	Geral (51) 3357-4100 Emergência (51) 3357-4130
Hospital de Pronto Socorro Av. Osvaldo Aranha, s/nº Plantão Permanente	(51) 3289-7999
Instituto de Cardiologia Av. Princesa Isabel, 395	Geral (51) 3230-3600 Emergência (51) 3230-3615
Coordenação de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre	(51) 3289-2472 / (51) 9 9318-5191 (51) 3289-2471 / (51) 3289-2401 epidemio@portoalegre.rs.gov.br
Hospital Conceição Av. Francisco Trein, 596	Geral (51) 3357-2000 Boletim (emergência) (51) 3357-2671 UDC (51) 3357-2665 Secretária (51) 3357-2671
Secretaria Municipal de Saúde	(51) 3289-2899 / (51) 3289-6800
CIEVS/SMS	daurapz@sms.prefpoa.com.br Daura Pereira Zardin (Responsável) (51) 3289-2459 / 2450 / 3969

RECURSOS EXTERNOS	
3Z (Porto Alegre- RS) (Guindastes, equipamentos pesados, caminhões para transporte de equipamentos pesados, etc.) (CONTRATO)	(51) 3375-8388 / 99576-5904 Guilherme Nadaletti Responsável
DARCY PACHECO (Porto Alegre- RS)	(51) 2103-1323 / (51) 9 9570-1500 (Cléber Martins Gerente Comercial)

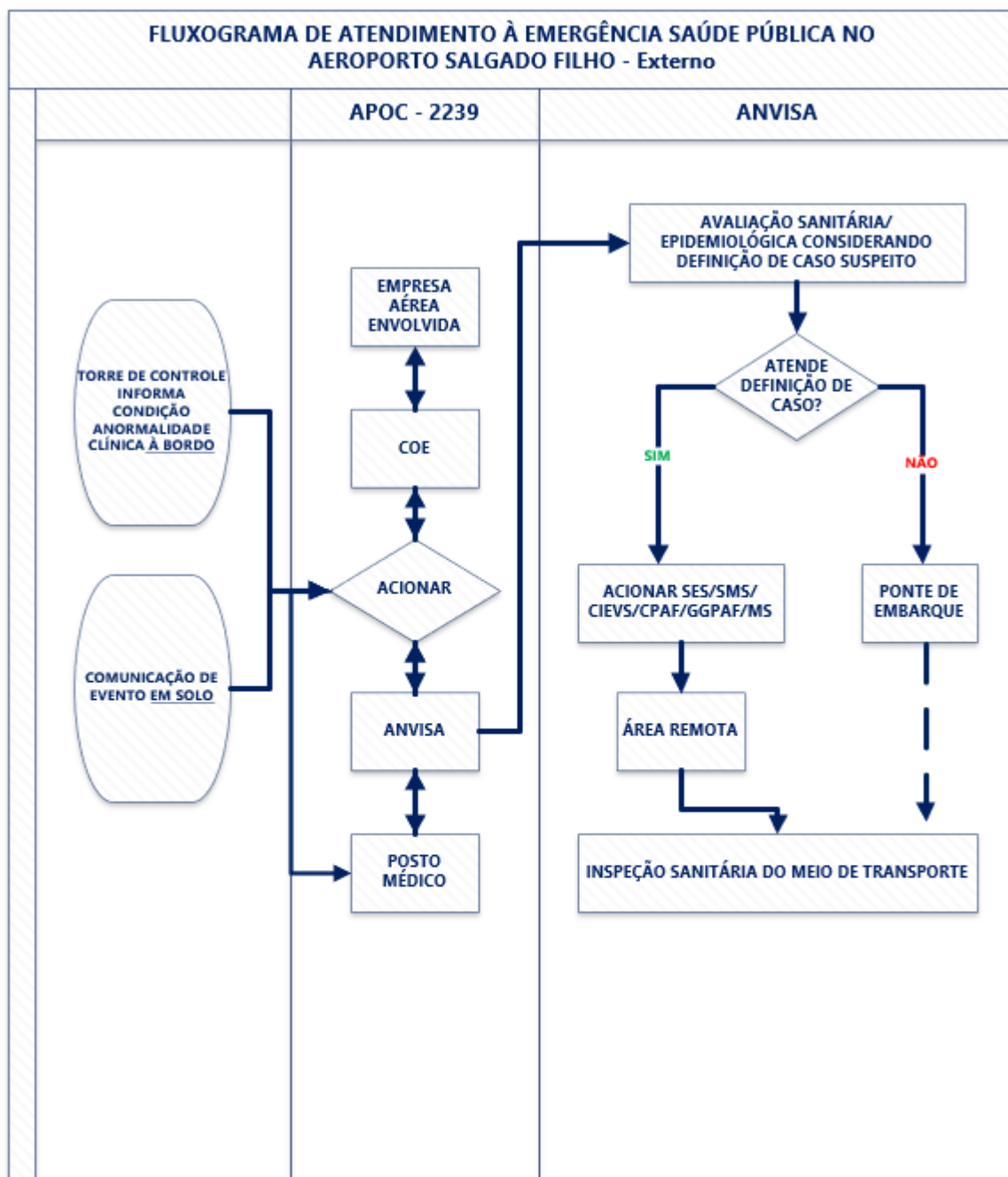
	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 46 de 106

(Guindastes, equipamentos pesados, caminhões para transporte de equipamentos pesados etc.)	
IRIGARAY (Porto Alegre- RS) (Guindaste tipo RT (rough terrain), tipo esteira treliçados 250 ton, rodoviário telescópicos 220,110,50 a 80 e 25 ton entre outros)	(51) 3357-7200
LATAM AIRLINES (São Paulo) (Equipamentos com capacidade para remover aeronaves até Código E)	MOC: 55 (11) 4517-2728 / 4517-2944 GRULC: 55 (11) 2445-2240 (11) 9 9897-6070 Everton.amieiro@latam.com
RECOVERY KIT – VIRACOPOS (Campinas SP) / (Aeroportos Brasil) (Composto por um trailer que pesa 18,3 ton, seis colinas infláveis, macacos hidráulicos, compressor, 4 cintas para içamento e demais acessórios capazes de levantar uma aeronave de até 223 ton)	(19) 3795-7920 / (19) 3795-7921 (19) 9 7111-8500
ULTRAPESA (Canoas - RS) (Guindastes, equipamentos pesados, caminhões para transporte de equipamentos pesados, etc.)	(51) 9 8171-8888 (André) / (51) 2102-1400 / (51) 9 8171-9999

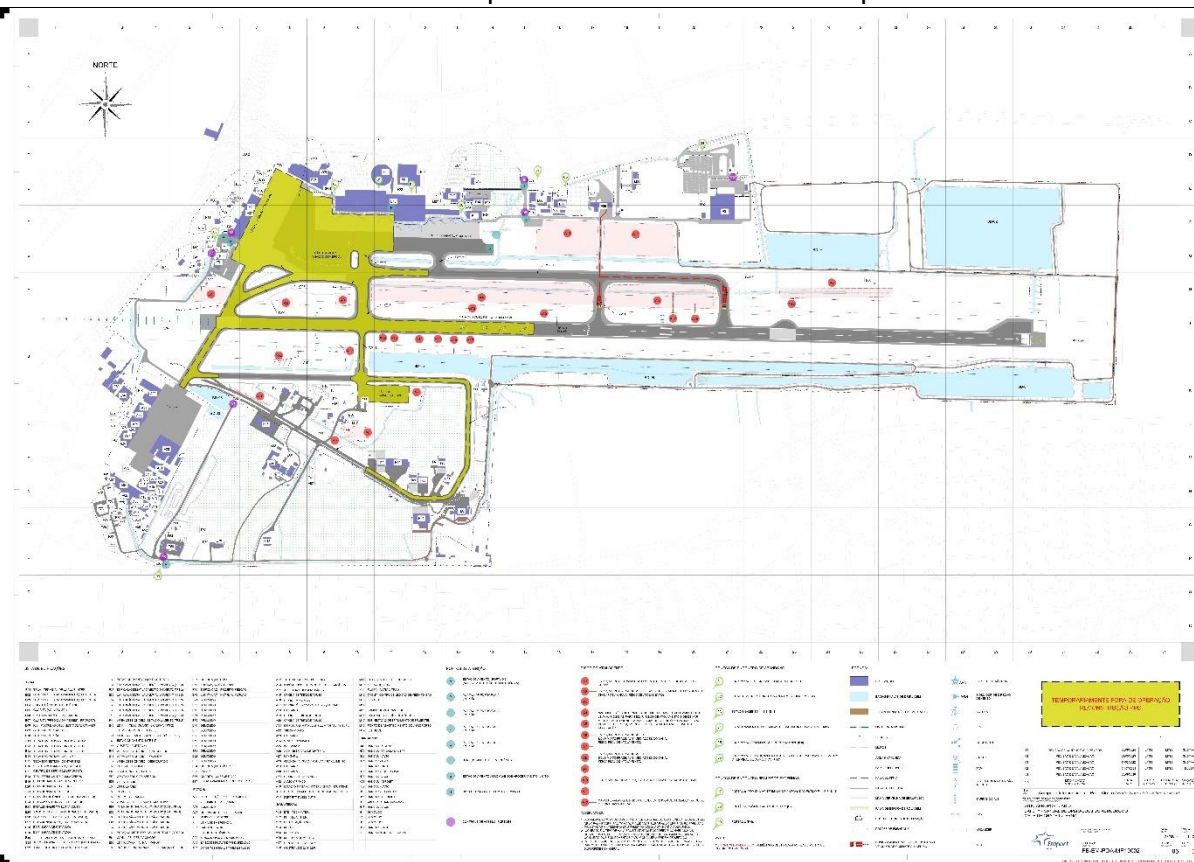
ANEXO II - Fluxogramas de Acionamentos



CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS (COE)
Gestor Resposta a Emergência (51) 99954-7031 Gestor Aeródromo/ Operações (51) 99888-9739 Gestor Segurança Operacional (51) 99584-1623 Gestor Avsec (51) 99843-1681 Gestor de Manutenção (51) 98021-3963



ANEXO III - Mapa de Grade Interno do Aeroporto



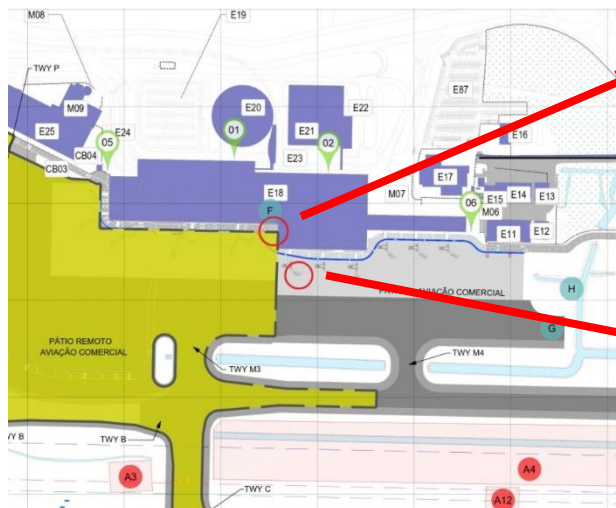
	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 50 de 106

ANEXO IV - Croqui das Áreas de Triage e Isolamento

ÁREA DE ISOLAMENTO:

PASSAGEIROS/TRIPULAÇÃO: TPS1 - SALA 111 e 112

Transporte através de ônibus ou ambulância até o hospital referenciado.



Salas de Embarque das
Remotas (111 e 112)

Posição 6

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 51 de 106

ANEXO V - Protocolo Operacional Padrão

Quadro 2 - Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 01	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
Propósito	Estabelecer as responsabilidades e ações para atendimento de evento de saúde a bordo.		
Âmbito	Aeroporto de Porto Alegre		
Prioridades	Suporte ao viajante afetado (suspeito ou acometido); Detecção, controle e resposta rápida a evento de saúde pública.		
Normas de segurança	Utilizar EPIs adequados RDC nº 21 de 28/03/2008 Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09		
Ações conjuntas de preparação	Alinhamento de abordagem conjunta entre a atenção à saúde e vigilância sanitária; Definição dos EPIs		
Notas	O evento também poderá se tratar de óbito a bordo		
Ações previstas no protocolo	Antes do Pouso da Aeronave: <u>O Comandante da aeronave ao tomar conhecimento do fato deverá:</u> a) Notificar o evento à Torre de Comando; b) Adotar, na aeronave, as medidas recomendadas pela Autoridade Sanitária e apoio médico; c) Informar, de imediato e quando houver alteração, ao Órgão de Controle de Tráfego Aéreo os seguintes dados: • Número de viajantes a bordo; • Número de viajantes com a suspeita; • Sinais e sintomas; • Estado geral do caso suspeito; • Ocorrência atendimento médico a bordo; • Dados dos casos suspeitos (nome, idade, sexo, assento); • Procedência do caso suspeito, incluindo suas escalas e conexões; • Se caso suspeito viaja só ou em grupo; • Tipo de aeronave; • Tempo estimado de voo até o pouso; • Autonomia de voo.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 52 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 01	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
	<u>Torre de Controle deverá:</u> • Repassar imediatamente estas informações ao APOC do aeroporto de Porto Alegre. <u>Operador do APOC deverá:</u> • Receber a informação e comunicar imediatamente à Autoridade Sanitária - ANVISA, ao serviço médico e à companhia aérea; • Após os acionamentos acima informar à VIGIAGRO, Receita Federal, Polícia Federal e ANAC, se couber. <u>O Centro de Operações deverá:</u> • De acordo com a avaliação de risco, realizada pela autoridade sanitária, indicar à Torre de Comando (TWR) o local de estacionamento da aeronave, optando pela posição a ser definida em conjunto com o órgão de vigilância sanitária. <u>Administração Aeroportuária deverá:</u> • Coordenar as ações que se fizerem necessárias, em conformidade às orientações da autoridade sanitária e a equipe médica do aeroporto; • Disponibilizar, em caso de necessidade de segregação dos passageiros contactantes, a área de triagem; • Verificar junto à Polícia Federal e a Receita Federal a forma de efetuar o controle migratório e alfandegário do caso suspeito e demais passageiros contactantes, se couber. Após o Pouso da Aeronave: <u>À Autoridade Sanitária - ANVISA compete:</u> • Avaliar o risco e, caso necessário, ativar a sala de triagem, sala de crise e comunicar imediatamente à vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde (SMS ou SES) Centro Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS; • Autorizar o desembarque do caso suspeito e dos seus contactantes;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 53 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 01	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
	• Caso seja necessária a realização da triagem dos demais passageiros, após realização de entrevista, orientar a procurar atendimento médico caso apresente sintomas compatíveis com o caso suspeito; • Caso o atendimento seja realizado a bordo, orientar os demais passageiros e tripulantes, a procurarem atendimento médico, caso apresentem sintomas compatíveis com o caso suspeito e autorizar o desembarque dos demais passageiros e tripulantes; • Preencher o(s) Termo(s) de Controle Sanitário de Viajante –TCSV do caso(s) suspeito(s) e contactantes; • Comunicar à VE necessidade de transferência do caso suspeito ao serviço de saúde apropriado; • Orientar a realização da limpeza e desinfecção da aeronave e proceder à inspeção sanitária, seguindo a legislação vigente; • Orientar a empresa aérea quanto ao tratamento dos resíduos sólidos (grupo A ou demais); • Orientar a realização da limpeza e desinfecção da ambulância e ou veículos utilizados no transporte do caso suspeito e proceder à inspeção sanitária. <u>À companhia aérea, compete:</u> • Fornecer à Autoridade Sanitária, sempre que solicitado, a lista de passageiros do voo, os dados sobre os viajantes disponíveis nos sistemas da Cia, a Declaração Geral da Aeronave e o registro de atendimento médico a bordo; • Garantir que seus funcionários ou terceirizados façam uso de EPI de acordo com a orientação da Autoridade Sanitária; • Acompanhar o passageiro segregado até o hospital referenciado, quando necessário, conforme orientação da autoridade sanitária; • Segregar a bagagem dos casos suspeitos e dar o tratamento conforme orientação da Autoridade Sanitária; • Apoiar a autoridade sanitária na comunicação junto aos viajantes. <u>À Equipe médica do aeroporto, compete:</u> • Comunicar a autoridade sanitária, imediatamente, quando houver suspeita de doença infectocontagiosa;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 54 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 01	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
	• Paramentar-se com os EPI adequados, antes de entrar em contato com o caso suspeito; • Avaliar os sinais e sintomas do viajante a bordo, após a autorização do comandante e da autoridade sanitária; • Avaliar os critérios clínicos para enquadramento como caso suspeito, de acordo com a definição do Ministério da Saúde; • Realizar o atendimento médico na ambulância (pátio) ou ainda na própria aeronave, de acordo com as condições clínicas do caso suspeito; • Desembarcar o caso suspeito e seus contactantes pela porta que possibilite o menor cruzamento possível com os demais passageiros, conforme orientação da autoridade sanitária; • Encaminhar o caso suspeito para o serviço de saúde apropriado, conforme orientações da autoridade sanitária.		

Quadro 3 - Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública em instalações aeroportuárias (solo)

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública em instalações aeroportuárias (solo)	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 02	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
Propósito:	Estabelecer as responsabilidades e ações para atendimento de evento de saúde pública no ambiente aeroportuário		
Âmbito:	Aeroporto de Porto Alegre		
Prioridades:	Suporte ao viajante afetado (suspeito ou confirmado); Detecção, controle e resposta rápida.		
Normas de segurança:	Utilizar EPI adequado. RDC nº 21 de 28/03/2008 Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09		
Ações conjuntas de preparação:	Alinhamento de abordagem conjunta entre a atenção médica e vigilância sanitária; Definição dos EPI		
Notas:	O evento também pode se tratar de óbito nas dependências do sítio aeroportuário.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 55 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública em instalações aeroportuárias (solo)	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 02	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
Ações previstas no protocolo:	Casos Suspeitos Identificados em Solo <u>A toda comunidade aeroportuária, compete:</u> • Informar ao Centro de Operações de Emergências do Aeroporto - COE, toda a identificação de um caso suspeito em qualquer área do aeroporto, seja passageiro, tripulante, ou qualquer outra pessoa. <u>Ao APOC, compete:</u> • Acionar o Serviço Médico e comunicar à ANVISA; • Comunicar à Receita Federal, Polícia Federal e VIGIAGRO, quando o caso estiver em área restrita, se couber; <u>Ao serviço médico do aeroporto, compete:</u> • Realizar atendimento em conjunto com a Autoridade Sanitária; • Avaliar os critérios clínicos para enquadramento como caso suspeito, de acordo com a definição do Ministério da Saúde; • Paramentar-se antes do atendimento, conforme suspeita do agravo; • Remover o caso suspeito ao posto médico ou local de triagem em área restrita e/ou área definida, evitando o trajeto por áreas com grande movimento de pessoas. <u>À administração aeroportuária compete:</u> • Coordenar as ações que se fizerem necessárias, em conformidade às orientações da Autoridade Sanitária e a equipe médica do aeroporto; • Disponibilizar a área de triagem, em caso de necessidade de segregação dos casos suspeitos; • Verificar junto à Polícia Federal e a Receita Federal a forma de efetuar o controle migratório e alfandegário do caso suspeito e demais contactantes, se couber; • Supervisionar e garantir a realização da limpeza e desinfecção das suas áreas conforme Procedimento 01; • Supervisionar e garantir a realização da limpeza e desinfecção dos seus equipamentos conforme Procedimento 01;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 56 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública em instalações aeroportuárias (solo)	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 02	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
	• Supervisionar e garantir a realização da limpeza e desinfecção das suas ambulâncias e ou ônibus de transporte de superfície empregados no transporte de casos suspeitos, conforme Procedimento 01; • Classificar os resíduos sólidos provenientes do atendimento, de acordo com as orientações da Autoridade Sanitária (grupo: A, B, C, D, E) e gerenciá-los conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. • Os efluentes sanitários provenientes do atendimento devem ser gerenciados conforme o Plano de Gerenciamento de Efluentes Sanitários <u>À Autoridade Sanitária - ANVISA compete:</u> • A avaliação do risco e, caso necessário, a comunicação imediata à vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde (SMS ou SES), conforme especificado no Plano Estadual e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS. • Comunicar à VE necessidade de transferência do caso suspeito ao serviço de saúde apropriado; • Preencher o(s) Termo(s) de Controle Sanitário de Viajante - TCSV do caso(s) suspeito(s) e contactantes; • Encaminhar imediatamente o TCSV do caso suspeito para a Vigilância Epidemiológica - VE; • Orientar os contactantes identificados no aeroporto a procurar atendimento médico caso apresentem sintomas após o período de incubação da doença, conforme definição vigente do Ministério da Saúde; • Orientar a realização da limpeza e desinfecção da ambulância responsável pelo transporte e o trajeto percorrido pelo caso suspeito. <u>Aos Operadores de Aeronaves, compete:</u> • Fornecer a lista de viajantes com as informações solicitadas pela Autoridade Sanitária; • Acompanhar o passageiro segregado até o hospital referenciado, quando necessário, conforme orientação da Autoridade Sanitária;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT		Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001		13/09/2024
			Pág nº 57 de 106

Nome do protocolo: Atendimento de Evento de Saúde Pública em instalações aeroportuárias (solo)	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 02	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Aeroporto e Companhias Aéreas
	• Segregar a bagagem dos casos suspeitos e dar o tratamento conforme orientação da Autoridade Sanitária; • Apoiar a Autoridade Sanitária na comunicação junto aos viajantes; • Impedir o embarque do caso detectado no momento do “check-in” ou nos portões de embarque, informando ao COE para os acionamentos necessários.		

Quadro 4 - Nome do protocolo: Comunicação em emergência de saúde pública

Nome do protocolo: Comunicação em emergência de saúde pública	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 03	Responsável: ANVISA, Administração Aeroportuária, demais instituições do SUS e Companhias Aéreas
Propósito	Estabelecer responsabilidades e a estratégia de divulgação de informações relativas ao evento de saúde pública aos viajantes, comunidade aeroportuária, público externo e imprensa.		
Âmbito	Aeroporto		
Prioridades	• Mitigar o risco de disseminação da doença por meio da comunicação de risco; • Evitar a divulgação de informações divergentes pelos diversos atores envolvidos na resposta ao evento; • Estabelecer uma relação de confiança entre a equipe envolvida na resposta ao evento, o responsável pela aeronave e viajantes; • Orientar o comandante da aeronave e tripulantes a tomarem decisões por meio da disponibilização de informações claras, completas e fundamentadas aos passageiros; • Sensibilizar e influenciar o comportamento do comandante da aeronave e viajantes envolvidos no evento de saúde pública de forma a assegurar a adequada aplicação das medidas de controle, prevenção e monitoramento; • Manter o comandante da aeronave e viajantes informados e atualizados quanto a natureza e risco do evento de saúde pública em curso, medidas de controle, prevenção e monitoramento adotadas pela Autoridade Sanitária; • Fornecer informações claras, confiáveis e em tempo oportuno acerca do evento de saúde pública para a comunidade aeroportuária, familiares e imprensa.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024 Pág nº 58 de 106

Nome do protocolo: Comunicação em emergência de saúde pública	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 03	Responsável: ANVISA, Administração Aeroportuária, demais instituições do SUS e Companhias Aéreas
Normas de segurança	RDC nº 21 de 28/03/2008 Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09		
Ações conjuntas de preparação	• Elaboração de informes para comunicação de risco, medidas de controle, medidas de prevenção e ações de monitoramento do evento de saúde pública em curso; • Definição prévia das áreas para o atendimento (familiares, imprensa etc.).		
Notas	• Caso haja informe específico, de acordo com a emergência, ele será divulgado oportunamente. • Identificar um único porta-voz com a imprensa, a fim de concentrar as informações em uma única pessoa e evitar ruídos.		
Ações previstas no protocolo	<u>À administração aeroportuária compete:</u> • Fornecer, por meio de sua assessoria de imprensa, suporte técnico e operacional para comunicação de risco aos viajantes, imprensa, comunidade aeroportuária e familiares; • Disponibilizar espaço com estrutura para atendimento à imprensa, comunidade aeroportuária e familiares; • Participar com a ANVISA de atendimento à imprensa, familiares e comunidade aeroportuária; • Divulgar informes disponibilizados pela ANVISA sobre a avaliação de risco do evento, medidas de prevenção, controle e monitoramento adotadas pela equipe de resposta durante o período de ocorrência do evento no ponto de entrada; • Distribuir material informativo e disponibilizar em suas ferramentas de comunicação oficial (sites, e-mails, redes sociais, banners etc.) orientações de saúde aos viajantes e à comunidade aeroportuária; • Quando disponível, veicular por meio do sistema de som do terminal de passageiros informes sonoros solicitados pela ANVISA; • Quando solicitado ou por exigência do cenário/natureza do evento, apoiar e realizar entrevistas ou coletivas de imprensa, definindo previamente com a ANVISA os responsáveis por transmitir informações à imprensa (porta-vozes);		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024 Pág nº 59 de 106

Nome do protocolo: Comunicação em emergência de saúde pública	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 03	Responsável: ANVISA, Administração Aeroportuária, demais instituições do SUS e Companhias Aéreas
	• Monitorar rumores e notícias divulgadas nos meios de comunicação e redes sociais acerca do evento, avaliando com a ANVISA a necessidade de resposta oficial. <u>A ANVISA compete:</u> • Articular com a administração aeroportuária e demais órgãos de saúde envolvidos na resposta ao evento a elaboração de informes e comunicados direcionados ao comandante da aeronave, viajantes, imprensa, comunidade aeroportuária e familiares; • Elaborar e fornecer à administração do terminal os informes e avisos a serem divulgados as empresas aéreas, comandantes, viajantes, imprensa, comunidade aeroportuária e familiares; • Manter comunicação com os viajantes embarcados e contactantes sobre o evento de saúde em curso, informando-os e atualizando-os acerca da avaliação de risco, medidas de prevenção, controle e monitoramento adotadas para resposta ao evento; • Disponibilizar ao comandante da aeronave e administradora/empresa Área <i>speech</i> que deverá ser utilizado a bordo e/ou sala de entrevista/triagem para comunicação do evento de saúde em curso e para divulgação e atualização das medidas de prevenção, controle e monitoramento adotadas pela Autoridade Sanitária; • Submeter à Assessoria de Comunicação da ANVISA os pedidos de entrevista ou de participação em coletivas de imprensa, cabendo a essa avaliar a pertinência, identificar a fonte adequada (porta voz ANVISA), bem como orientar e acompanhar a interlocução com os veículos de comunicação; • Realizar atendimento à comunidade aeroportuária e familiares quando requerido pelos atores envolvidos ou quando o cenário do evento exigir; • Realizar a comunicação/notificação (CIEVS, VE, CVPAF, CRPAF, GGPAF, GIMTV, demais postos envolvidos) de acordo com o fluxo estabelecido; • e demais orientações específicas pertinentes.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024 Pág nº 60 de 106

Nome do protocolo: Comunicação em emergência de saúde pública	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 03	Responsável: ANVISA, Administração Aeroportuária, demais instituições do SUS e Companhias Aéreas
	<u>Demais instituições do Sistema Único de Saúde (CIEVS, Vigilância Epidemiológica, Lacen etc.)</u> • Manter comunicação com a ANVISA durante o evento em curso de forma a transmitir informações preliminares coletadas durante o processo de investigação epidemiológica que poderão impactar no estabelecimento de medidas de prevenção e controle, formulação de exigências sanitárias; • Formalizar à ANVISA, durante e/ou após finalização dos trabalhos a bordo, as recomendações técnicas para resposta ao evento de saúde pública em curso, em especial quando tratar-se de medida restritiva que interfira no tráfego e comércio internacional; • Participar da elaboração de informes para comunicação de risco, medidas de controle, medidas de prevenção e ações de monitoramento do evento de saúde pública em curso; • Participar com a ANVISA e administração aeroportuária de atendimento à imprensa, familiares e comunidade portuária; • Após conclusão do processo de investigação epidemiológica, encaminhar ao posto local da ANVISA relatório final da investigação que providenciará envio das conclusões e eventuais laudos clínicos ou ambientais ao meio de transporte; <u>Aos operadores de aeronaves compete:</u> • Comunicar imediatamente ao COE do aeroporto as anormalidades clínicas ocorridas a bordo de aeronave e os casos suspeitos detectados pelos funcionários em outros locais do aeroporto, por exemplo, no momento do <i>check-in</i>; • Anunciar speech na aeronave afetada quando solicitado pela Autoridade Sanitária; • Colaborar com a ANVISA na divulgação de informações aos viajantes, na sala de entrevista/triagem; • Realizar atendimento aos familiares, em conjunto com a Administrador.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 61 de 106

Quadro 5 - Nome do protocolo: Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Nome do protocolo: Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 04	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Ponto de Entrada, Prestadoras de serviço
Propósito	Estabelecer as responsabilidades e padronizar procedimentos para o gerenciamento de resíduos sólidos atendimento a evento de saúde pública.		
Âmbito	Pontos de Entrada, aeroportos, portos, passagens de fronteiras, recintos alfandegados, estabelecimentos de atividade diversa localizada nessas áreas e em veículos terrestres que operam transporte coletivo internacional de viajante, aeronaves e embarcações		
Prioridades	Assegurar o correto manejo de resíduos sólidos em pontos de entrada		
Normas de segurança	• Uso de EPI para execução das atividades; • Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que Regulamenta a Lei nº.12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; • Resolução-RDC nº. 345, de 16 de dezembro de 2002; • Resolução-RDC nº. 56, de 06 de agosto de 2008; • Resolução- RDC nº 351, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002; • Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001; • ABNT NBR 11174/1990; • ABNT NBR 13221/2003; • ABNT NBR 10004/2004; • Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09		
Ações conjuntas de preparação	Os prestadores de serviço e empresas geradoras de resíduos devem estabelecer plano de gerenciamento de resíduos conforme regulamento.		
Notas			
Ações previstas no protocolo	O programa de gestão de resíduos sólidos deve ser documentado conforme as diretrizes abaixo. Administradora e prestadoras de serviço: Deve dispor de responsável técnico, com registro ativo junto ao seu conselho de classe, sendo responsável pela supervisão das atividades de gerenciamento de resíduos sólidos no aeroporto, porto, recinto alfandegado e posto de passagem constituinte do quadro de funcionários da administradora aeroportuária/portuária ou da empresa;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 62 de 106

Nome do protocolo: Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 04	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Ponto de Entrada, Prestadoras de serviço
	Deve definir as responsabilidades dos envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos: Pela retirada dos resíduos das aeronaves, embarcações e veículos de transporte coletivo internacional de viajantes; Pelo transporte de resíduos dentro da área aeroportuária, portuária, área alfandegada e passagem de fronteira até a central de resíduos sólidos; Pela central de resíduos sólidos, quando couber; Pelo transporte da central de resíduos ao destino final ou tratamento; Pelo tratamento térmico dos resíduos na área primária, quando couber; Pela supervisão das atividades de gerenciamento de resíduos sólidos no aeroporto, porto, área alfandegada e passagem de fronteira até a central de resíduos sólidos; Apresentar documentações válidas: alvarás, licenças (ambientais municipais, estaduais e federal - IBAMA) e autorizações (RDC 345/2002), quando couber. Caracterização da atividade: Identificar os locais de geração, condições de operacionalidade, características e quantitativo dos resíduos gerados, conforme disposto no artigo 10, da RDC 56/2008. Essas informações devem contemplar, minimamente, as seguintes informações: classificação dos resíduos gerados; volume de resíduos gerados de acordo com o grupo; frequência da coleta e transporte para cada grupo de resíduo; rota da coleta, estando identificado os pontos de coleta por grupo de resíduo; tipo de transporte para cada grupo de resíduo, destacando características, vida útil e plano de manutenção para cada equipamento; tipo de tratamento por grupo, de acordo com regulamento; local de destinação final dos resíduos, por grupo. Operacionalização Descrever detalhadamente as etapas que compõem o gerenciamento de resíduos sólidos para cada grupo de resíduos no aeroporto, porto, recinto alfandegado e posto de passagem conforme procedimentos descritos no		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 63 de 106

Nome do protocolo: Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 04	Responsáveis: ANVISA, Administradora do Ponto de Entrada, Prestadoras de serviço
	capítulo IV da RDC 56/2008, recomenda-se que seja elaborado um fluxograma onde constem todos os processos e operações empregadas; Apresentar plano de contingência para gerenciamento de resíduos sólidos perigosos e de risco, conforme artigos 64 a 67, do Decreto nº 7404/2010; No plano de gerenciamento de resíduos deverão estar previstas situações em que a operacionalização saia da rotina, como por exemplo, aumento de resíduos grupo A quando de emergências em Saúde Pública, greves em empresas envolvidas, fechamento/interdição de aterros, etc.; No caso da retirada de resíduos sólidos de aeronaves ou embarcações, apresentar fluxograma das atividades desenvolvidas, bem como a caracterização do(s) itinerário(s) a serem percorridos pelos veículos transportadores até o armazenamento intermediário ou central de resíduos; As empresas que prestam serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos devem dispor de AFE, conforme previsão legal disposta na lei 9782/99, Anexo II, item 5.1.10, e RDC 345/2002. A Central de Resíduos deverá atender ao disposto no artigo 79 da RDC 56/2008.		

Quadro 6 - Nome do protocolo: Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI e Isolamento.

Nome do protocolo: Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Isolamento	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 05	Responsáveis: ANVISA, Órgãos intervenientes, Administradora, Prestadora de Serviço
Propósito	Estabelecer orientação para uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e isolamento de casos suspeitos.		
Âmbito	Pontos de Entrada		
Prioridades	Proteger os trabalhadores de pontos de entrada de exposição a fatores de risco à saúde.		
Normas de segurança	NR 06 - Equipamento de Proteção Individual RDC nº 56, de 06 de agosto de 2008		
Ações conjuntas de preparação	Preparação e disponibilização de EPI de acordo com normas técnicas e orientação dos órgãos competentes.		
Notas			
Ações previstas no protocolo	1. Medidas Preventivas: a. Frequente higienização das mãos com água e sabão;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 64 de 106

Nome do protocolo: Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Isolamento	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 05	Responsáveis: ANVISA, Órgãos intervenientes, Administradora, Prestadora de Serviço
	b. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, pode ser utilizado gel alcoólico para as mãos; c. Etiqueta respiratória: • Utilizar lenço descartável para higiene nasal; • Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; • Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. 2. Atendimento ao viajante: 2.1 Para os meios de transporte (aeronaves, embarcações, veículos terrestres coletivos de passageiros) com evento a bordo: a. Todos os trabalhadores da linha de frente da ANVISA, Receita Federal, Polícia Federal, Vigiagro ou operadores que tenham contato com os viajantes provenientes dos meios de transporte devem realizar frequente higienização das mãos com água e sabonete ou com gel alcoólico, de uso específico para as mãos, e utilizar máscara de acordo com o evento suspeito quando realizar abordagem direta ao viajante. Na presença de secreções ou fluidos, utilizar luvas de procedimentos, óculos de proteção e avental descartável. 2.2 Para os meios de transporte (aeronaves, embarcações, veículos terrestres coletivos de passageiros) com identificação de viajante que apresente sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito: a. Os trabalhadores que realizarem abordagem direta ao viajante (até um metro de distância), durante a inspeção ou no desembarque, devem usar os seguintes EPI: • Em caso de doença de transmissão aérea: utilizar máscara cirúrgica (barreira de proteção) ou respirador particulado (PFF2/N95 e PFF3/N99 ou N100). Com risco de espargimento de gotículas, os óculos de proteção devem ser utilizados; • Em caso de risco de contato das mãos do profissional com fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados deve-se utilizar luvas de		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024
		Pág nº 65 de 106

Nome do protocolo: Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Isolamento	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 05	Responsáveis: ANVISA, Órgãos intervenientes, Administradora, Prestadora de Serviço
	procedimentos, avental descartável de manga longa e óculos de proteção. Nota 1: Os viajantes que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito devem utilizar máscara de proteção respiratória desde o momento em que for identificada a suspeita, de acordo com o agravo, até a chegada à unidade de referência. Nota 2: Ressalta-se a necessidade de higienização das mãos antes e após a retirada de EPI. Nota 3: Os trabalhadores responsáveis pela realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção do meio de transporte devem utilizar os EPI conforme previsto na RDC 56/2008 e quadros disponíveis no final do documento. 3 Identificação do executor (administradora e prestadora de serviço): a. Dispor de responsável técnico, com registro ativo junto ao seu conselho de classe, responsável pela supervisão das atividades de limpeza e desinfecção no aeroporto ou porto, constituinte do quadro de funcionários da administradora aeroportuária, portuária ou passagem de fronteira; b. Definir as responsabilidades do supervisor para as atividades de limpeza e desinfecção; c. Destinar um local apropriado, dentro de suas instalações, ou contratar serviços especializados, autorizados a realizar a limpeza e desinfecção dos uniformes e EPI, sendo proibida a realização desta atividade por parte dos trabalhadores em domicílio próprio. 4 Operacionalização: a. Os EPI devem ser usados tão somente durante as atividades que o exijam; b. Após o uso dos EPI estes deverão ser limpos, desinfetados ou descartados; c. Para reaproveitamento dos EPI utilizados nos procedimentos de limpeza e desinfecção, deverá ser realizado processo de desinfecção por imersão (obedecido o tempo de contato e diluição recomendados		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 66 de 106

Nome do protocolo: Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Isolamento	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 05	Responsáveis: ANVISA, Órgãos intervenientes, Administradora, Prestadora de Serviço
pelo fabricante), seguido de enxágue com água potável, secagem e disposição em local apropriado previamente definido. Os procedimentos deverão ser submetidos à aprovação da Autoridade Sanitária competente; d. Os trabalhadores responsáveis pela realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção na infraestrutura devem utilizar os EPI conforme previsto na RDC 56/2008 e quadros disponíveis ao final deste protocolo. 5 Procedimentos para colocação e retirada de EPIs Procedimento para COLOCAÇÃO de EPI Reunir todo equipamento necessário ↓ Realizar higienização das mãos ↓ Colocar EPIs: • Colocar máscara cirúrgica • Colocar luvas de procedimentos e demais equipamentos, conforme atividade a ser desenvolvida ↓ Iniciar atividade designada			

Quadro 7 - Nome do protocolo: Adequação de Área Reservada para Atendimento a Viajantes Afetados e Contactantes

Nome do protocolo: Adequação de Área Reservada para Atendimento a Viajantes Afetados e Contactantes	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 06	Responsáveis: ANVISA, Administradora
Propósito	Estabelecer requisitos mínimos para área reservada para entrevista de pessoas enfermas ou suspeitas.		
Âmbito	Ponto de Entrada do Aeroporto de Porto Alegre		
Prioridades			

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024
		Pág nº 67 de 106

Nome do protocolo: Adequação de Área Reservada para Atendimento a Viajantes Afetados e Contactantes	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 06	Responsáveis: ANVISA, Administradora
Normas de segurança	NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; RDC nº 21 de 28/03/2008; Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 395/09; Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2012.		
Ações conjuntas de preparação	Articulação entre ANVISA e a Administradora do ponto de entrada para definição de local adequado para atendimento a viajantes		
Notas			
Ações previstas no protocolo	AMBIENTE: Área de Recepção/Entrevista de Passageiros: Deve atender ao número total de passageiros da maior aeronave que o aeroporto tenha capacidade de receber. Sugere-se uma área de 1,20 m2 por pessoa. Devem ser instaladas cadeiras para os passageiros de superfície não porosa para fácil limpeza e desinfecção; Possuir, no mínimo, um sanitário masculino, um feminino e um adaptado para portadores de necessidades especiais. Alternativamente os sanitários, masculino e feminino, podem ser adaptados para portadores de necessidades especiais, sem a necessidade de apresentar sanitário exclusivo adaptado; Possuir recepção com mesa, computador e armários para os profissionais que irão orientar os passageiros quanto ao preenchimento dos formulários etc.; Possuir reservatórios para a dispensação de resíduos sólidos; Possuir bebedouros (água filtrada); Prever depósito de material de limpeza dotado de tanque, abrigo temporário de resíduos, ponto de água, armário para guarda de materiais de limpeza e Equipamentos de Proteção Individual ou outra solução previamente aprovada pela Autoridade Sanitária; No caso de porto, as entrevistas poderão ser realizadas a bordo da embarcação.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001	13/09/2024
		Pág nº 68 de 106

Nome do protocolo: Adequação de Área Reservada para Atendimento a Viajantes Afetados e Contactantes	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 06	Responsáveis: ANVISA, Administradora
	OBS: Os pontos de atuação deverão prover acesso ao serviço de transporte de viajantes enfermos ou suspeitos, para remoção ao serviço de saúde de referência. Instalações Prediais da Área Reservada: Possuir sistema de aviso sonoro para veiculação de informações aos passageiros; Cabe a administradora disponibilizar infraestrutura de Tecnologia da Informação (pontos de rede lógica e telefonia, computadores, impressoras multifuncionais etc.); Contar com equipe para execução de limpeza, desinfecção e gerenciamento de resíduos sólidos; Possuir sistema de climatização, preferencialmente, não compartilhado com os demais ambientes do aeroporto ou porto. Quando isto não for possível o retorno de ar do sistema deve ser isolado, não sendo permitida, em nenhuma hipótese, a mistura com o ar retorno dos demais ambientes do aeroporto/porto; Prever grupo gerador para alimentação de energia elétrica nas emergências. 3. Acabamentos de Paredes, Pisos, Tetos e Bancadas: Os materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos e tetos dos ambientes devem ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, conforme preconizado no manual Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies; Devem ser sempre priorizados materiais de acabamento que tornem as superfícies monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza frequente; Os requisitos de limpeza e sanitização de pisos, paredes, tetos, pias e bancadas devem seguir as normas contidas no manual Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. 4. Operacionalização dos Fluxos da Área Reservada: 1. Recepção → espera → triagem → saída.		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT		Rev. nº 02
	FB-EM-POA-PL22001		13/09/2024
			Pág nº 69 de 106

Nome do protocolo: Adequação de Área Reservada para Atendimento a Viajantes Afetados e Contactantes	Atualizado em: 10/09/2019	Número: 06	Responsáveis: ANVISA, Administradora
	2. Recepção → espera → triagem → encaminhamento ao serviço de saúde. A porta de acesso à Área de Recepção/Entrevistas de Passageiros: deve permitir que os dois fluxos de passageiros sejam seguidos evitando o cruzamento deles; A Área de Recepção/Entrevistas de Passageiros deve ser bloqueada para a circulação (acesso restrito) bem como devem ser isoladas de forma a impedir qualquer cruzamento com outros passageiros e tripulantes; O local deve permitir fácil e rápida evacuação, com o menor trânsito possível entre outras áreas; Os procedimentos de triagem serão definidos de acordo com os protocolos específicos para o evento;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 70 de 106

ANEXO VI - Procedimento: Limpeza e Desinfecção de Ambientes, Equipamentos, Utensílios Potencialmente Contaminados, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários

 ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Data de preparação: 25-07-2019	Páginas: 3	Nome do procedimento: Limpeza e Desinfecção de ambientes potencialmente contaminados, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários
Procedimento nº 01			
Propósito: limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos que foram expostas a agentes contaminantes a bordo do meio de transporte coletivo ou nas áreas de infraestrutura. Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários contaminados.			Responsáveis: Administração aeroportuária, portuária e passagem de fronteira; Empresas de limpeza e desinfecção, gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários
Âmbito: infraestrutura e meios de transporte com identificação de caso suspeito potencialmente contaminado por agente biológico.			
Preparação para as ações e tarefas: • Manter a equipe técnica capacitada para a execução do procedimento e uso adequado de EPI, conforme procedimento preconizado pela Autoridade Sanitária e Protocolo nº 08; • Isolar a área a ser limpa ou desinfetada; • Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPI; • Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante a realização do procedimento; • Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas e aparadas; • Utilizar produtos saneantes devidamente regularizados na ANVISA; • Utilizar produto de limpeza ou desinfecção compatível com material do equipamento\superfície; • Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Se for necessário, deve ser utilizada a técnica de varredura úmida; • Manter um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Efluentes Sanitários para aplicação em eventos de interesse à saúde pública; • Providenciar área ou equipamento para armazenar e segregar os resíduos sólidos e efluentes em local exclusivo e reservado dos demais; • Providenciar o tratamento dos resíduos sólidos e efluentes sanitários de acordo com a orientação da Autoridade Sanitária; • Definir área de expurgo para limpeza e desinfecção de equipamentos, utensílios, materiais e EPI e para o fracionamento e diluição de produtos de limpeza/higienização.			
Ações e tarefas			
Passo 1	Limpeza		
	Proceder a limpeza da área definida pela Autoridade Sanitária da seguinte maneira: 1. Retirar os resíduos e descartar como resíduo tipo A ou sob orientação da Autoridade Sanitária;		

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 71 de 106

	- Remover, sempre que houver, matéria orgânica em superfícies e tratar como resíduo tipo A; - Friccionar as superfícies com pano embebido com água e detergente neutro ou enzimático, entre outros de igual ou superior eficiência; - Limpar as superfícies de toda área contaminada, bem como as superfícies potencialmente contaminadas, tais como cadeiras/ poltronas, cama, corrimãos, maçanetas, apoios de braços, encostos, bandejas, interruptores de luz e ar, controles remotos, paredes adjacentes e janelas, com produtos autorizados para este fim; - Enxaguar com água limpa ou pano úmido (considerando o local e produto utilizado); - Secar com pano limpo, sempre que necessário; - Promover o descarte dos panos utilizados na operação como resíduo tipo A; - Descartar como resíduo tipo A, os equipamentos e EPI que não possam ser limpos, ou higienizados, ou desinfetados com segurança.
Passo 2	Desinfecção
	Após limpeza da área contaminada: - Aplicar sobre a área contaminada o desinfetante indicado; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante do produto; - Seguir procedimento de desinfecção conforme indicação do fabricante do produto; - Promover o descarte dos panos utilizados na operação como resíduo tipo A; - Descartar os equipamentos, utensílios, materiais e EPI, que não possam ser desinfetados com segurança, como resíduo tipo A.
Esgotamento dos Efluentes Sanitários Contaminados: - Utilizar os EPI adequados, de acordo com o Protocolo nº 08; - Os efluentes devem ser removidos e armazenados em equipamento exclusivo de forma a evitar que contamine outros efluentes; - O tratamento deverá ser seguro e efetivo de forma a eliminar o agente contaminante e evitar a contaminação do meio ambiente, conforme orientação da autoridade competente na seara.	
Equipamentos de Proteção Individual (EPI): - Utilizar os EPI adequados, de acordo com a legislação vigente, frente à possibilidade de contato das roupas e da mucosa ocular com secreções do caso suspeito. Os calçados devem ser fechados e impermeáveis; - Lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene adequada das mãos com água e sabão; O uso de álcool gel 70% é pertinente após higiene adequada das mãos; - A relação mínima de EPI está disponível no Anexo I da RDC nº 56 de 06 de agosto de 2008 e Protocolo nº 08.	
Normas ou orientações de segurança: Após o procedimento de limpeza e desinfecção, nunca tocar desnecessariamente superfícies, equipamentos, utensílios ou materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) enquanto estiver com luvas, para evitar a transferência de microrganismos para outros ambientes e pessoas.	
Área de expurgo: Local apropriado para receber, conferir, limpar/higienizar ou desinfetar e secar, exclusivamente, os equipamentos, utensílios ou materiais utilizados para a execução dos serviços de higienização/limpeza ambiental (ex.: containers de transporte de resíduos sólidos, líquidos, lixeiras, panos-de-chão, baldes, mops, vassouras, entre outros similares), desprezo seguro de efluentes e águas servidas. <u>Infraestrutura da área de expurgo:</u> - As dimensões da área de expurgo devem ser compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas e sua demanda; - Deve ser projetado de forma a evitar o cruzamento de fluxos (contaminados e limpos);	

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 72 de 106

- Áreas úmidas com paredes e pisos em materiais lisos, não porosos, laváveis, sem reentrâncias e com declive direcionado para os sistemas de escoamento (ralos e grelhas) de forma a evitar acúmulo de líquidos;
- As áreas secas e úmidas devem ser separadas fisicamente;
- Teto fechado e com forro em material liso, não poroso e lavável;
- Portas (quando couber) em material resistente, liso, não poroso e lavável;
- Pia ou tanque de cuba funda, com oferta de água fria e quente, dotada de ralo de contenção de resíduos sólidos removíveis, com anteparo de segurança para contenção de excessos, preferencialmente sobre bacia de contenção;
- Ralos sifonados e grelhas, dimensionados de acordo com a demanda de uso, dotados de contenção de resíduos sólidos removíveis e sem acesso a vetores;
- Bancadas em material liso, não poroso, resistente e lavável, com alturas ergonômicas;
- Pia(s) para lavagem das mãos dotada de sabão líquido e papel toalha;
- Iluminação adequada e ampla ventilação para renovação do ar;
- Proporcionar conforto térmico aos trabalhadores;
- Armários ou prateleiras (em material higienizável) exclusivos e acesso restrito para guarda de produtos químicos em área seca, quando couber;
- O fracionamento e diluição de produtos de limpeza deve ser realizado em área apropriada e exclusiva à finalidade, ventilada, dotada de dispenser (dosadores), lava-olhos e demais equipamentos necessários;
- Armários exclusivos para armazenamento (guarda) de EPI, em área seca;
- Lixeira com tampa acionada por pedal;
- Os resíduos gerados no ambiente devem ser acondicionados de forma segura, respeitando a classe desses resíduos.

Materiais necessários para uso diário

- Os EPI devem atender ao disposto no Protocolo nº 8;
- Os produtos desincrustantes/desinfetantes devem atender sua finalidade de aplicação e possuir notificação ou registro válidos na ANVISA; disponibilizados por meio de dosadores ou prontos para uso, rotulados, respeitando os prazos de validade, conforme orientação do fabricante; Devem ser armazenados em local exclusivo, seguro, seco e arejado;
- Os materiais utilizados para limpeza, ou higienização, ou desinfecção dos equipamentos e utensílios devem atender as necessidades a qual se propõem.

Notas:

- As empresas responsáveis pela limpeza, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes sanitários devem manter os procedimentos operacionais padronizados (POP), incluindo o uso de EPI, descritos, atualizados e acessíveis;
- Somente usar desinfetantes para as superfícies que foram contaminadas por agentes biológicos ou por indicação da ANVISA;
- Não se deve usar vassouras para varrição a seco, ar comprimido, lava-jatos, pois podem espalhar material infeccioso através do ar. Se assentos, colchões, travesseiros, lençóis, cobertores, carpetes etc., constituídos por materiais permeáveis, estiverem contaminados com sangue ou fluidos corporais (fezes, vômitos etc.), estes devem ser removidos e descartados pelos métodos utilizados para material de risco biológico. Alguns

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 73 de 106

assentos, que permitam limpeza e desinfecção, devem ser isolados e retirados do meio de transporte para a realização do procedimento em local especializado.

- A área seca do expurgo pode contemplar área de recebimento, conferência, checagem, armazenagem; caso a área de expurgo seja dotada de janelas, estas devem ser teladas;
- Os trabalhadores devem ser capacitados previamente às atividades que deverão desenvolver;
- Cabe a Vigilância Sanitária analisar e aprovar, previamente, o Projeto da área de expurgo.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 74 de 106

ANEXO VII - Procedimentos para as Ações a Serem Realizadas Conforme os Critérios da OMS

Esta parte do Plano de Contingência tem por finalidade orientar as ações a serem desenvolvidas, com vistas a prestar atendimento aos viajantes acometidos de sinais clínicos que se enquadram ou não como suspeitos e que venham a ocorrer no Aeroporto ou Aeronave:

NOTA 1 - São consideradas viajantes todas as pessoas que se encontrem a bordo de aeronaves; as recém-desembarcadas, enquanto não forem liberadas; as que estejam aguardando conexão ou continuidade de voos e as que tenham feito o respectivo check-in para o embarque.

NOTA 2 - No caso de viajantes que embarcam nos Aeroportos de origem, já na condição de pacientes, não caberá à Superintendência do Aeroporto nenhuma responsabilidade quanto à prestação de atendimento médico ou remoção, podendo, nestes casos, conceder as facilidades de locomoção nas áreas do Aeroporto e realizar as comunicações e apoio que se fizerem necessárias, quando solicitadas pelos interessados.

NOTA 3 - Tratando-se de mal súbito ou ferimentos decorrentes de acidentes aeronáuticos, os procedimentos para o atendimento são os previstos no PLEM.

NOTA 4 - Para os casos de emergência médica que venham a ocorrer na área do Aeroporto, com outros usuários/transeuntes, a Superintendência do Aeroporto prestará o respectivo atendimento médico de emergência e/ou remoção previstos no PLEM.

Procedimentos de Atendimento do Viajante a bordo e em solo

Equipe de atendimento:

- a) **quantitativo** - o quantitativo de fiscais se dará em conformidade com os Recursos Humanos disponíveis no PVPAF/Porto Alegre, devidamente identificados. A equipe poderá ser ampliada, em caso de necessidade, com servidores do MS, SES ou SMS;
- b) **atribuições** - um dos fiscais preencherá o TCSV do viajante apresentando sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito e o outro fará a coleta de informações da tripulação, bem como os contatos e encaminhamentos necessários.

Ferramentas:

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 75 de 106

a) Formulários:

- TCSV - Termo de Controle Sanitário de Viajante;
- Formulário de Saúde Pública para Identificação de Passageiros.

b) Maleta contendo: EPI (Máscara, luva, avental, protetor auricular, óculos protetores), álcool-gel, prancheta, caneta.

Procedimento: dentro da aeronave

Após a equipe médica do PPS avaliar os critérios clínicos (sinais e sintomas/início do quadro) e concluir pela suspeita de que o evento é de interesse da saúde pública, compete à Autoridade Sanitária a avaliação do risco sanitário.

A equipe da ANVISA fará o levantamento de informações: o viajante está só ou em grupo? Quais os países por onde passou? Houve atendimento a bordo por profissional de saúde? Houve orientação terapêutica durante o voo fornecida por empresa de suporte aeromédico? Houve consumo de medicamentos a bordo?

Orientar para que os passageiros permaneçam sentados até autorização do desembarque.

Caso a suspeita seja de transmissão aérea por gotículas (caxumba, coqueluche, rubéola, difteria faríngea), todos os passageiros das duas fileiras anteriores e posteriores e a fileira do passageiro deverão preencher o TCSV e depois desembarcar. Após a saída do passageiro acometido, demais viajantes podem ser liberados para o desembarque.

Caso a suspeita seja de transmissão por aerossóis (Tuberculose pulmonar e laríngea, Sarampo, Varicela, SARS) preencher o TCSV de todos os passageiros. Após a saída do passageiro acometido, demais viajantes podem ser liberados para o desembarque.

Caso a suspeita seja de transmissão oro - fecal (diarreias infecciosas), preencher TCSV apenas das poltronas vizinhas (laterais).

Os viajantes desembarcados serão conduzidos à sala de triagem para preenchimento do TCSV e outros encaminhamentos que forem necessários.

Verificar maleta de medicamentos da aeronave para confirmar o uso e validade dos medicamentos.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02
		13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 76 de 106

Requisitar documentos:

- a) Cópia da GD (*General Declaration*);
- b) Lista de passageiros;
- c) Cópia de Formulário de atendimento de intercorrência médica a bordo;
- d) Caso algum documento não seja prontamente entregue, enviar Notificação com a solicitação.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 78 de 106

ANEXO IX - Ficha PLEM

Este questionário disponibilizado ao setor do APOC, tem por objetivo a melhoria da qualidade das informações que chegam ao APOC e consequentemente ao SME (Serviço Médico de Emergência).



MENU DE SELEÇÃO DE FICHAS DO PLEM

Condição de URGÊNCIA 	Condição de SOCORRO 
Emergência em áreas AQUÁTICAS 	Emergência MÉDICA 
Artigos PERIGOSOS 	Incêndios FLORESTAIS 
Terminal em INCÊNDIO 	Desastres NATURAIS 
Queda de ENERGIA 	Controle de MULTIDÕES 
Interdição de PISTA COM AERONAVE 	Interdição de PISTA SEM AERONAVE 

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 79 de 106

ANEXO X - Ofício da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria Municipal de Saúde com Orientações para a Barreira Sanitária

11/08/2021

SEI/PMPA - 14415574 - Ofício



**prefeitura de
PORTO ALEGRE**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SMS

Ofício - nº 26 Novo / 2021

Porto Alegre, 11 de junho de 2021.

De: Coordenação - DVS

Para: GOL Linhas Aéreas, LATAM Airlines, Azul Linhas Aéreas e Copa Airlines

Assunto: Orientações Barreira Sanitária Porto Alegre

Prezados Senhores,

Considerando que no dia 10 de maio de 2021, a OMS classificou a variante B.1.617, ou variante delta, do vírus Sars-Cov-2 como Variante de Preocupação (VOC). A variante delta, identificada pela primeira vez na República da Índia, é a quarta a ser declarada como Variante de Atenção pela OMS. Esta variante levou o sistema de saúde e o sistema funerário da Índia ao colapso, e já ameaça outros países.

Diante disso, o governo federal emitiu a Portaria nº 654 de 28 de maio de 2021 que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Com o objetivo de identificar e monitorar passageiros que ingressam em Porto Alegre eventualmente contaminados com Variante de Preocupação (VOC) do vírus Sars-Cov-2 (B.1.617) e outras VOCs, e minimizar o impacto da entrada de novas VOCs no município, que possam elevar os índices de contágio e/ou colapsar o sistema de saúde, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre em conjunto com a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul realizará um controle sanitário no aeroporto internacional Salgado Filho por 14 dias.

Para isso, encaminhamos o texto abaixo para leitura e orientação aos passageiros:

"Speech 1": em Português

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e da importância no monitoramento da chegada de novas variantes ao estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre em conjunto com a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul informam que está sendo realizado controle sanitário no desembarque do Aeroporto de Porto Alegre. Para facilitar o processo de triagem estamos disponibilizando um QR Code para acessar o formulário on-line que deverá ser preenchido e enviado. Este formulário também poderá ser preenchido junto à equipe de Vigilância em Saúde no desembarque. Passageiros com viagem internacional nos últimos 14 dias, ou com algum sintoma de Covid-19 devem comparecer ao controle sanitário no desembarque.

In English:

Due to the new coronavirus pandemic and the importance of sanitary surveillance for avoiding the introduction of new variants in the state of Rio Grande do Sul, the Porto Alegre city hall informs: A Sanitary Control is being conducted on arrival in Porto Alegre Airport. In order to facilitate the trial process, we are providing a QR Code to access the online form that must be completed and submitted. This form can also be filled in with the Health Surveillance team upon arrival. If you have traveled internationally in the last 14 days, or have any symptoms of covid, go to the sanitary control area upon landing.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 80 de 106

11/06/2021

SEI/PMPA - 14415574 - Ofício



Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Ritter, Diretor-Geral**, em 11/06/2021, às 17:37, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Fett Sparta de Souza, Secretário Municipal**, em 11/06/2021, às 17:49, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **14415574** e o código CRC **32FC051C**.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 81 de 106

ANEXO XI - Ação de Controle Sanitário e Rastreamento de Variantes do Sars-Cov-2 no Aeroporto Internacional Salgado Filho - Procedimentos e Resultados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Orientações sobre cuidados do viajante em isolamento e de seus contactantes

(Imprimir duas vias - uma será entregue para o paciente e a outra deverá ficar retida na Unidade de triagem)

1 - Comportamento

- Permanecer em casa em quarto individual e bem ventilado. Se não for possível, outros moradores da casa devem permanecer a um metro de distância (distância de um braço esticado de um adulto) da pessoa em isolamento. Encontrar uma lixeira com tampa para uso individual.
- Ao circular em locais comuns da casa, manter janelas e portas abertas.
- Definir um ajudante se necessário, de preferência sem doenças crônicas (Pressão alta, diabetes, etc)
- Não receber visitantes em hipótese alguma durante o período de isolamento.
- A pessoa em isolamento deve sair de casa somente em casos de emergência e sempre usando máscara. Preferencialmente, não utilizar ônibus ou lotação. Se tiver falta de ar, considerar chamar uma ambulância (SAMU 192); já em casos mais brandos, utilizar um transporte em veículo particular (com janelas abertas) se possível.

2 - Utilização de máscaras

- Se for disponível um cômodo para isolamento, não é necessário o uso da máscara enquanto estiver sozinho dentro dele. Não tendo um cômodo disponível para tal, é recomendado o uso de máscaras quando outras pessoas estiverem no mesmo cômodo.
- Tomar cuidados ao espirrar e tossir - cobrir o nariz e boca, utilizando a parte interna do cotovelo ou um papel descartável, quando for tossir ou espirrar. Lavar as mãos com água e sabão/detergente ou aplicar álcool gel após.
- Cuidadores/familiares devem usar máscara sempre que estiverem no mesmo ambiente do paciente.
- Para retirar a máscara, deve-se retirar sem tocar na parte da frente, retirando-a por trás. Após sua retirada, colocar em um saco plástico se for colocar no lixo ou colocar imediatamente em uma bacia ou balde de molho. Após, fazer lavagem adequada das mãos com água e sabão/detergente ou álcool gel.

3 Medidas de Higiene

- A higiene das mãos pode ser feita com álcool em gel se não estiverem com sujeira perceptível - caso estejam, deve ser feita com água e sabão ou detergente. Sempre nos seguintes momentos:
 - Antes e após contato com outra pessoa, antes e após preparação de alimentos, antes e após a utilização do banheiro, após espirrar, tossir ou coçar o nariz ou olhos e sempre que as mãos parecerem sujas ou tiver sido feito o uso de álcool gel por várias vezes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



- A pessoa em isolamento deve ter toalha para banho e rosto que não seja utilizada por outras pessoas e que devem ser trocadas e lavadas sempre que estiverem muito molhadas. As toalhas devem ser lavadas ou deixadas de molho e guardadas separadas das outras roupas e toalhas de outras pessoas, sempre que possível. Se possível, secar as mãos com toalhas de papel.
- O ajudante deve evitar contato com qualquer tipo de secreção da pessoa em isolamento. Se o contato for necessário, utilizar máscara e higienizar as mãos antes e depois de colocar e retirar a luva e a máscara. Superfícies utilizadas com alta frequência (como criados-mudos, mesas, escrivaninhas etc..) devem ser limpas com álcool 70% ou com outro desinfetante diariamente.
- Lenços de bolso de tecido não devem ser utilizados.

4 - Cuidado com itens pessoais

- Roupas de cama, toalhas, copos e talheres devem ser de uso exclusivo da pessoa em isolamento. Após lavados, esses itens podem ser reutilizados. A roupa de quem estiver em isolamento (assim como roupa de cama e toalhas) não deve ser misturada com a das outras pessoas da casa e deve ser colocada em saco plástico até a lavagem em separado, que deve acontecer assim que possível.
- Evitar contato direto da pele com os materiais contaminados (fraldas, toalhas por exemplo). Pode-se utilizar luvas para o seu manuseio. Se forem luvas de limpeza, devem ser lavadas após uso.

5 - Descontinuidade do Isolamento

- Se os exames descartarem que se trata de uma infecção pelo coronavírus, o isolamento deve terminar assim que os sintomas gripais forem resolvidos.
- Se os exames confirmarem a infecção pelo coronavírus, o isolamento deve terminar após pelo menos 10 dias do início dos sintomas e desde que a pessoa esteja assintomática nas últimas 24 horas. Caso não haja melhora do quadro após este período, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para que seja feita a reavaliação.

6 - Testagem de contactantes domiciliares

- Todos os contactantes domiciliares de pessoas com casos confirmados (por exame PCR ou TR Ag) devem ser avaliados pela equipe da Unidade de Saúde. Para essas pessoas, será solicitado exame de PCR, que deve ser realizado entre 2-8 dias depois do início dos sintomas ou da data da coleta do exame da pessoa do domicílio confirmado para COVID-19. Entre em contato com a equipe de saúde para realizar a avaliação dos contatos domiciliares e encaminhar a testagem necessária (telefones das US - ver em 'Lista de postos de saúde - A a Z').

Caso o contactante domiciliar já tenha tido exame positivo para COVID (PCR ou TR antígeno) nos últimos 90 dias e estiver assintomático, não é necessário realizar nova coleta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**EXAME****TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO SARS-COV-2**

NOME COMPLETO: _____

CPF: _____

PASSAPORTE: _____

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

RESULTADO: () REAGENTE (Detected) () NÃO REAGENTE (Not detected)

Amostra: () swab nasal () swab de orofaringe () swab de nasofaringe

Marca do teste: _____

Lote: _____

Validade: _____

Observações:

1. Resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo SARS-Cov-2, especialmente quando a probabilidade de doença for alta, como em contactantes de pacientes positivos, em regiões com alta prevalência de COVID-19 ou na presença de sintomas (tais como febre ou calafrio, dor de garganta, tosse, cefaléia, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, adinamia, mialgia).
2. Resultado não reagente não exclui a obrigatoriedade da quarentena para passageiros com origem nos países elencados na Portaria Nacional 654/2021, conforme consta no Termo de Controle Sanitário do Viajante.
3. Resultado reagente confirma a infecção ativa pelo vírus da Covid-19, devendo o cidadão cumprir isolamento domiciliar por, no mínimo, dez dias a contar do início dos sintomas ou da data do teste, nos casos de pessoas sem sintomas.

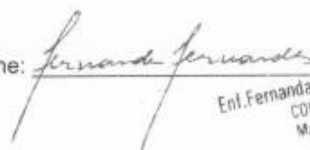
Observations:

1. A negative result does not rule out the possibility of Sars-Cov-2 infection, especially when probability of disease is high, such as positive case contacts, regions with high prevalence of COVID-19 or in the presence of symptoms (fever or chills, sore throat, cough, headache, runny nose, diarrhea, loss of smell or taste, adynamia, myalgia).
2. A negative result does not exclude mandatory isolation for passengers who traveled to countries of Portaria Nacional 654/2021, as stated in the Termo de Controle Sanitário do Viajante.
3. A positive result confirms active infection with the virus that causes Covid-19, and the citizen must comply with home isolation for, at least, ten days from the onset of symptoms or the date of the test, in cases of people without symptoms.

Horário do exame: ____:____

Data do exame: ____/____/____

Técnico responsável pela realização do exame: _____

Ent. Fernanda dos Santos Fernandes
COREN/RS 0114217
Matrícula 574342.0
Diretora Adjunta
DVS SMS PMPA

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 84 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR E
AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DO VIAJANTE**

Eu, _____, CPF/passaporte nº _____, passageiro (a) do voo _____, empresa _____, residente/com estadia na (rua, número/complemento) _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado _____, declaro que fui devidamente informado(a) pela equipe técnica da AÇÃO DE CONTROLE SANITÁRIO PARA PREVENÇÃO À COVID-19 NO AEROPORTO SALGADO FILHO, sobre a necessidade de isolamento e da importância das medidas de isolamento social, inclusive para as pessoas que residem/com estadia ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no mesmo endereço, com início em ____/____/2021 e término em ____/____/2021.

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Assinatura do passageiro: _____

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 85 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



AÇÃO DE CONTROLE SANITÁRIO E RASTREAMENTO DE VARIANTES DO SARS-COV-2 NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO

Porto Alegre, 06 de julho de 2021

Considerando que são definidos como serviços públicos e atividades essenciais os de trânsito e transporte internacional de passageiros e os de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral, conforme descrito nos incisos V e XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, atualizado pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020;

Considerando a transmissão de Variantes de Especial Preocupação (VOC), de acordo com a Nota Técnica Nº 718/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que apresenta *orientações sobre vigilância, medidas de prevenção, controle e de biossegurança para casos e contatos relativo a Variante de atenção e/ou preocupação (VOC) Indiana B.1.617 e suas respectivas sublinhagens*.

Considerando que a introdução de novas variantes da Covid-19 no país potencialmente ocorre através de portos, aeroportos e fronteiras;

Considerando a Portaria Federal nº 655, de 23 de junho de 2021, que restringe o acesso de estrangeiros e exige a testagem de viajantes oriundos do exterior em até 72 horas anteriores ao momento do embarque;

Considerando a ação de controle sanitário, ocorrido no Aeroporto Internacional de Porto Alegre - RS com o objetivo diagnóstico situacional através da vigilância ativa de viajantes que chegaram ao Estado oriundos de outros locais do Brasil, em especial daqueles onde já foi identificada a variante Delta ou que realizam conexão (São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná) de viajantes oriundos do exterior e que podem trazer variantes para o Município.

A seguir é apresentado relatório com principais resultados e recomendações gerados a partir da ação de controle sanitário e rastreamento de variantes do SARS-CoV-2, realizada no Aeroporto Internacional Salgado Filho do dia 14 ao dia 28 de junho de 2021.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 86 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Síntese da ação, Principais Resultados e Recomendações

- Com o objetivo de planejar ações conjuntas para conter ou retardar a chegada de novas variantes no Estado, Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS/PMMA), Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) e ANVISA realizaram reunião no mês de maio de 2021.
- A ação realizada pela Diretoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre foi viabilizada a partir da disponibilidade de testes rápidos de antígeno (TRAg) pela SES-RS, aprovada em reunião colegiada da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), e pelas parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (por meio de projeto de extensão com a Escola de Enfermagem e curso de Saúde Coletiva) e com a empresa operadora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a FRAPORT.
- Os insumos foram disponibilizados pela SES/RS (testes rápidos de antígeno: TRAg) e pela SMS/PMMA (cabines de testagem, computadores, EPIs, laudos, máscaras e álcool em gel para casos reagentes e contatos). O custo aproximado em TRAg foi de R\$ 310.150,00 (trezentos e dez mil cento e cinquenta reais).
- A ação ocorreu das 14:00 horas do dia 14 até às 02:00 do dia 28 de junho de 2021, diariamente abrangendo desde o horário do primeiro até o último voo, das sete horas da manhã até a uma hora da madrugada do dia seguinte.
- A equipe técnica envolveu 51 trabalhadores de todas as áreas da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, 61 estudantes e 11 professores de diferentes cursos da área da saúde da UFRGS, além de apoio logístico de transporte de ambas as instituições.
- A população convidada a realizar o teste rápido foi de aproximadamente 79.686 passageiros com desembarque previsto, sendo que 6.256 passageiros foram efetivamente testados.
- Identificados 55 (0,87%) viajantes com exame 'reagente' ao TRAg. Destes, 43 (78,18%) tiveram como destino final o interior do estado e 12 (21,81%) com destino final em Porto Alegre. Daqueles com destino fora de Porto Alegre, um era viajante a turismo com destino a Gramado, mas que acabou realizando estadia em hotel na Capital para manter o isolamento, e outro era viajante em trânsito com destino ao Uruguai, mas que antes de seguir viagem ficou em Porto Alegre e realizou coleta de PCR, o que totalizou 14 amostras encaminhadas para RT-PCR.
- 29 das 55 casos reagentes (52,7%) declararam presença de sintomas na notificação do e-SUS, o que incluiu alguns passageiros que relataram sintomas leves durante os últimos 2 ou 3 dias antes da testagem e que inicialmente autodeclararam-se assintomáticos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



- Daqueles 14 casos 'reagentes' ao TR-Ag e com swab posteriormente coletado e enviado para análise por RT-PCR, 12 (85,71%) resultaram 'positivo' e estão com as amostras guardadas para envio à genotipagem junto a FEEVALE. A equipe de pesquisa do laboratório da FEEVALE integra o projeto *Corona-ômica BR MCTIC/Finep**: Rede Nacional de genomas, exoma e transcriptoma de Covid-19 para identificação de fatores associados à dispersão da epidemia e severidade. Duas amostras não foram viáveis, sendo uma com resultado negativo e outra indeterminada, dentre as 14 coletadas e encaminhadas para PCR.



- O fluxo constante e intenso de desembarque de *viajantes a turismo*, seja retornando de cidades turísticas do nordeste e sudeste, seja vindo oriundos do norte, nordeste e sudeste para visitar a região da Serra Gaúcha (Gramado, Canela e outras cidades), apontam para a necessidade imediata de *medidas de educação em saúde para a população e de alerta para as companhias aéreas, devido à presença de viajantes sintomáticos*. Apesar de o regramento sobre o manejo de passageiros sintomáticos não constar das normativas da ANAC e da ANVISA (Portaria 655/2021), *medidas de precaução devem ser adotadas para identificar passageiros sintomáticos e evitar o embarque de casos suspeitos nas aeronaves*.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 88 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



RELATÓRIO ANALÍTICO

Planejamento da Ação:

Com o objetivo de planejar ações conjuntas para conter ou retardar a chegada de novas variantes no Estado, a estratégia começou a ser pensada a partir de reunião entre Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e ANVISA, realizada no mês de maio.

A disponibilidade de testes rápidos de antígeno (TR-Ag) pela SES-RS foi garantida por meio de aprovação em reunião colegiada da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O delineamento da estratégia (ANEXO 1), assim como a composição das equipes de trabalho, foram definidos a partir da parceria entre DVS-SMS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio de projeto de extensão com a Escola de Enfermagem e coordenação do projeto por docentes do curso de Saúde Coletiva. A organização do espaço de trabalho foi possível a partir da parceria com a empresa operadora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a FRAPORT.

O seguimento do monitoramento dos casos com resultado de TR-Ag 'reagentes' foi viabilizado a partir do fluxo de coleta de swab e envio para análise por RT-PCR em até 24 horas após o caso identificado no aeroporto, por laboratório contratualizado junto a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/SMS. A análise inicial das amostras quanto ao CT ("Cycle Threshold"), que definiu a viabilidade da amostra para posterior genotipagem, também foi realizada pelo laboratório contratualizado, no momento de realização do RT-PCR. As amostras com CT compatível foram transportadas pela equipe técnica da DVS-SMS aos laboratórios que realizaram a genotipagem - FEEVALE (9) e LACEN-RS (3) e estão em fase de análise genômica. Espera-se que os resultados estejam disponíveis e sejam publicados nos próximos 20 dias, nos meios de comunicação oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e em publicações geradas pelo Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde - CIEVS de Porto Alegre/RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Dados gerados na ação:**

- Foram abordados passageiros de todos os voos pousados no desembarque nacional (aproximadamente 79.686 pessoas, conforme previsão da Fraport) e também encaminhados, a partir da ANVISA, passageiros do desembarque internacional para testagem rápida de identificação de antígeno viral.
- Foram 6.256 (7,85%) passageiros testados, resultando em 55 (0,88%) identificados como reagentes ao TR-Ag. Destes, 43 (78,18%) tiveram como destino final o interior do estado e 12 (21,81%) tinham Porto Alegre como destino final. Daqueles com destino fora de Porto Alegre, um era viajante a turismo com destino a Gramado, mas que acabou realizando estadia em hotel na Capital para manter o isolamento, e outro era viajante em trânsito com destino ao Uruguai, mas que antes de seguir viagem ficou em Porto Alegre e realizou coleta de PCR, o que totalizou 14 amostras encaminhadas para RT-PCR.
- Autodeclararam-se sintomáticos no formulário 22 (40%) dos 55 casos com exame reagente, no entanto, ao exame na sala de coleta, alguns inicialmente autodeclarados assintomáticos relataram sintomas leves durante os últimos 2 ou 3 dias antes da testagem e, na notificação do e-SUS, 29 das 55 casos reagentes (52,7%) declararam presença de sintomas.
- Daqueles 14 casos 'reagentes' ao TR-Ag e com swab posteriormente coletado e enviado para análise por RT-PCR, 12 (85,71%) resultaram 'positivo' e estão com as amostras armazenadas para envio à genotipagem junto a Universidade FEEVALE. A equipe de pesquisa do laboratório da FEEVALE integra o projeto *Corona-ômica BR MCTIC/Finep*: Rede Nacional de genomas, exoma e transcriptoma de Covid-19 para identificação de fatores associados à dispersão da epidemia e severidade*. Duas amostras não foram viáveis, sendo uma com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



resultado negativo e outra indeterminada, dentre as 14 coletadas e encaminhadas para PCR. Um caso positivo, residente de Santa Maria/RS, foi encaminhado à UPA Moacyr Scliar onde procedeu-se à coleta de RT-PCR no dia seguinte da chegada a Porto Alegre, cuja amostra foi encaminhada ao Lacen e teve a confirmação da variante Gamma (P.1). Este viajante foi removido de ambulância para o município de Santa Maria, que se responsabilizou pelo transporte.

- Tecnicamente, a ação foi viabilizada com o envolvimento de
 - 51 trabalhadores da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Porto Alegre, integrantes das equipes de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador. São servidores municipais das categorias médica, enfermagem, odontologia, terapia ocupacional, medicina veterinária, além de auxiliares administrativos, agentes de fiscalização, estagiários de enfermagem e residentes de vigilância em saúde da Escola de Saúde Pública e de Saúde Coletiva da UFRGS.
 - 61 estudantes e 11 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir de projeto de extensão coordenado pela Escola de Enfermagem. O projeto integrou os cursos de Farmácia, Serviço Social, Medicina, Odontologia, Saúde Coletiva, Enfermagem, com estudantes com estas formações e também da Biologia e da Medicina Veterinária, além de profissionais integrantes da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.



	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 91 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Perfil dos viajantes e dos voos no contexto da pandemia:

- Fluxo constante de desembarque de viajantes a turismo para a cidade de Gramado e região, provenientes das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país;
- Quantidade expressiva de 'viajantes a turismo', representando ao menos 50% da amostra coletada e reagente;
- Viajantes idosos e pessoas com apenas uma dose da vacina, retornando de viagem turística em cidades do nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Ceará), inclusive residentes de cidades do interior do Rio Grande do Sul;
- Viajantes adultos não vacinados a turismo e a trabalho em cidades do sul (Paraná e Santa Catarina) e sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo), residentes em Porto Alegre, na região metropolitana e em cidades polos do Estado (Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria).
- Viajantes vindos do exterior e que desembarcaram de voos de conexão em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná argumentam que já fizeram o exame RT-PCR, conforme exigido pela [Portaria 654/2021](#) e, por este motivo, a maioria não realizou o teste ofertado;
- Viajantes autodeclarados 'vacinados', com parte destes ainda querendo ser testados. Foram 11 'reagentes' com 2 doses há mais de 15 dias, e 10 vacinados com 1 dose, de um esquema de 2 doses.
- Viajantes sintomáticos e preocupados com seu estado de saúde, buscando o serviço de testagem.
- Relatos de passageiros acerca do trabalho das companhias aéreas no contexto da pandemia:
 - Indiferença de algumas companhias aéreas quanto ao estado de saúde de passageiros sintomáticos que embarcam nesta condição;
 - Inexistência de triagem de sintomas antes do embarque;
 - Inexistência de isolamento do passageiro, se identificado ao longo do percurso que trata-se de caso sintomático.
 - Inexistência de distanciamento mínimo entre passageiros.

Acionamento da rede e monitoramento de casos

- As orientações prestadas imediatamente à identificação de cada caso, de forma completa e considerando o contexto de vida de cada passageiro, são fundamentais para o seguimento do cuidado e efetividade da coleta de PCR para investigação genômica.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 92 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



- A disposição das Secretarias Municipais de Saúde em fazer a busca ativa dos seus residentes, quando estes não tinham condições de retornar ao domicílio em veículo privativo/particular foi fator de sucesso para não expor os viajantes de transporte coletivo intermunicipal;
- Os casos 'reagentes' ao exame de TR-Ag de viajantes com destino fora de Porto Alegre (78,18% da amostra), foram comunicados ao Centro de Operações de Emergências da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (COE-RS), por email e em até 12 horas após a identificação do caso, com vistas à comunicação oportuna junto às regionais e municípios com responsabilidade sanitária sobre os mesmos.
- A disponibilidade de coleta em domicílio e em tempo oportuno (em até 24h após o caso identificado no aeroporto), por serviço conveniado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, garantiu as amostras necessárias para envio ao sequenciamento genético dos vírus presentes na secreção dos casos 'reagentes' de Porto Alegre.
- A disposição do SAMU e rede de urgências em acolher casos reagentes e com sinais de alerta foi fundamental para evitar desfechos desfavoráveis no ambiente da ação, permitindo a manutenção do foco na identificação de novos casos que estavam desembarcando no momento.
- Acionadas para comunicar a lista de passageiros contatos dos casos reagentes (sentaram-se à distância menor que 1,5m), as companhias aéreas pouco retornaram com tais informações, o que dificultou o rastreo de casos secundários.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 93 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



RECOMENDAÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES E EMPRESAS QUE OPERAM NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO

À OPERADORA DO AEROPORTO:

- Orientar o desembarque de passageiros e retirada de bagagens em pequenos grupos, de modo a evitar aglomerações;
- Ofertar sinalização e outras formas de comunicação para a orientação junto aos passageiros quanto a:
 - o Uso correto e constante de máscara;
 - o Uso de máscaras adequadas para uso dentro da aeronave;
 - o Manter sempre o distanciamento interpessoal mínimo;
 - o Realizar a higiene de mãos com água e sabão ou álcool 70%, bem como evitar tocar no rosto e mucosas.
 - o Não viajar com sintomas de COVID-19 e buscar a testagem quando suspeitar da infecção pelo SARS-CoV-2. Comunicar à companhia aérea acerca dos sintomas e suspeita de COVID-19.
- Em parceria com as companhias aéreas e para o casos indicados pelas mesmas, oferecer teste rápido de antígeno (TR-Ag) no serviço de saúde ao viajante mantido pela administradora do aeroporto. Esta ação visa a diminuir a circulação de passageiros sintomáticos e com COVID-19 dentro das aeronaves.

ÀS COMPANHIAS AÉREAS:

- Realizar triagem dos viajantes e fornecer uma declaração do viajante antes do embarque/ no check-in, com foco na identificação de casos sintomáticos. Esta ação orienta para:
 - o Impedir o embarque destes sintomáticos; ou
 - o Ofertar o TR-Ag (teste rápido de antígeno) para os casos sintomáticos, visando evitar o embarque apenas de casos 'reagentes'.
- Exigir e fiscalizar o uso adequado de máscaras dentro das aeronaves, garantindo o uso daquelas autorizadas conforme recomendação da ANVISA, ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias ([RDC nº 477, de 11 de março de 2021](#)).

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 94 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



- Fornecer máscara com proteção tripla (cirúrgica ou equivalente) ou superior (PFF2, N95 ou equivalente) aos passageiros durante o trajeto desde a decolagem até o desembarque nos seguintes casos:
 - o Se a máscara do viajante é de baixa qualidade (conforme RDC 477) - ofertar e solicitar a troca antes da decolagem e preferencialmente antes do passageiro adentrar na aeronave; ou
 - o Se o voo tiver duração maior que 3 horas (ABNT PR 1002:2020 ed.2) - ofertar na terceira hora de voo; ou
 - o Se o passageiro apresentar sintomas durante o voo - ofertar imediatamente quando identificado o passageiro sintomático.
- Em caso de identificação de passageiro sintomático durante o percurso:
 - o Ofertar e direcionar o passageiro a assento específico e reservado para esta finalidade, que garanta o distanciamento mínimo de 2 metros em relação aos demais passageiros.
 - o Ofertar máscara cirúrgica ao passageiro e exigir que o mesmo a utilize adequadamente durante todo o percurso do voo.
 - o Após o pouso e desembarque, devem ser fornecidas as adequadas orientações de isolamento e testagem do passageiro, com suporte do serviço de vigilância sanitária do aeroporto de desembarque;
 - o Incluir no [Plano de contingência da companhia aérea](#) as ações descritas acima.
- Bloquear assentos da aeronave garantindo o distanciamento mínimo entre passageiros.

À ANVISA:

- Verificar a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) e exame de PCR com resultado negativo em 100% dos viajantes provenientes de voos internacionais.
- Atualizar as normativas vigentes ([Portaria 655/2021](#); [RDC Nº 477/2021](#); [Portaria 630/2020](#)) e inserir a [triagem de sinais e sintomas de passageiros](#), bem como especificar a conduta a ser tomada pelas companhias aéreas nestes casos (ofertar máscaras cirúrgicas ou superior; ofertar testagem rápida);
- Atualizar as [orientações sobre o uso de máscaras em aeronaves](#) para:

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 95 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



- o Garantir o uso de, no mínimo, máscara de tripla camada ou equivalente pelos viajantes;
- o Exigir que a máscara de tripla camada ou equivalente destinada ao viajante seja ofertada pela companhia aérea (uma a cada 3 horas de voo ou caso o viajante não esteja com a máscara de qualidade mínima exigida no momento do embarque);
- o Exigir a disponibilidade de máscara cirúrgica (tripla camada) ou PFF2/N95 para viajantes sintomáticos identificados durante o voo/após a decolagem.
- Realizar ações de educação em saúde do viajante junto às companhias aéreas, com foco no uso adequado de EPI, distanciamento social, presença de sintomas sugestivos de Covid-19;
- Realizar campanhas de educação em saúde do viajante, com foco em mudanças de atitude da população, visando evitar a circulação desnecessária durante a pandemia e fornecendo informações acerca do risco das novas variantes do vírus.

ÀS EMPRESAS DE TURISMO:

- Certificar-se de que hotéis e demais empresas parceiras exerçam boas práticas de cuidados sanitários para diminuir os riscos de transmissão do SARS-CoV-2, apresentando tais informações aos viajantes;
- Prestar informações sobre cuidados e estimular medidas de proteção aos viajantes (mascaramento, higiene de mãos e distanciamento social), bem como suporte assistencial nos casos de adoecimento durante a viagem;

À POPULAÇÃO VIAJANTE:

- Evite viagens desnecessárias;
- Opte por roteiros que garantam o distanciamento social e demais medidas de preventivas;
- Se a viagem for inevitável, prefira realizar passeios com o seu núcleo familiar (apenas com pessoas que residem na mesma casa);
- Se tiver que viajar sozinho, evite dormitórios compartilhados.
- Evite excursões e viagens em grupos, que não fornecem a manutenção do distanciamento social durante todo o percurso e passeios;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 96 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



- Garanta estoques de máscaras e álcool em gel em quantidade e qualidade adequados e suficientes para uso durante toda a viagem (ida e volta);
- Não realize passeios em meios de transporte sem janelas ou com as mesmas fechadas. Exija que as janelas sejam mantidas sempre abertas e que todos os integrantes estejam de máscara.
- Certifique-se de que haja distanciamento mínimo de 1,5 a 2 metros para tirar a máscara e alimentar-se. Evite bares e restaurantes que não garantam o distanciamento entre as mesas.
- Se sentir sintomas de COVID-19 (sintomas gripais incluindo febre, calafrios, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, ou também anosmia, agnosia e diarreia), procure um serviço de saúde imediatamente e realize o teste. Isole-se e não exponha outras pessoas ao risco de adoecimento. Se necessário, transfira a data de retorno e mantenha-se hospedado num mesmo local até o término dos sintomas. Comunique a companhia aérea/de transporte rodoviário e/ou a empresa de turismo.

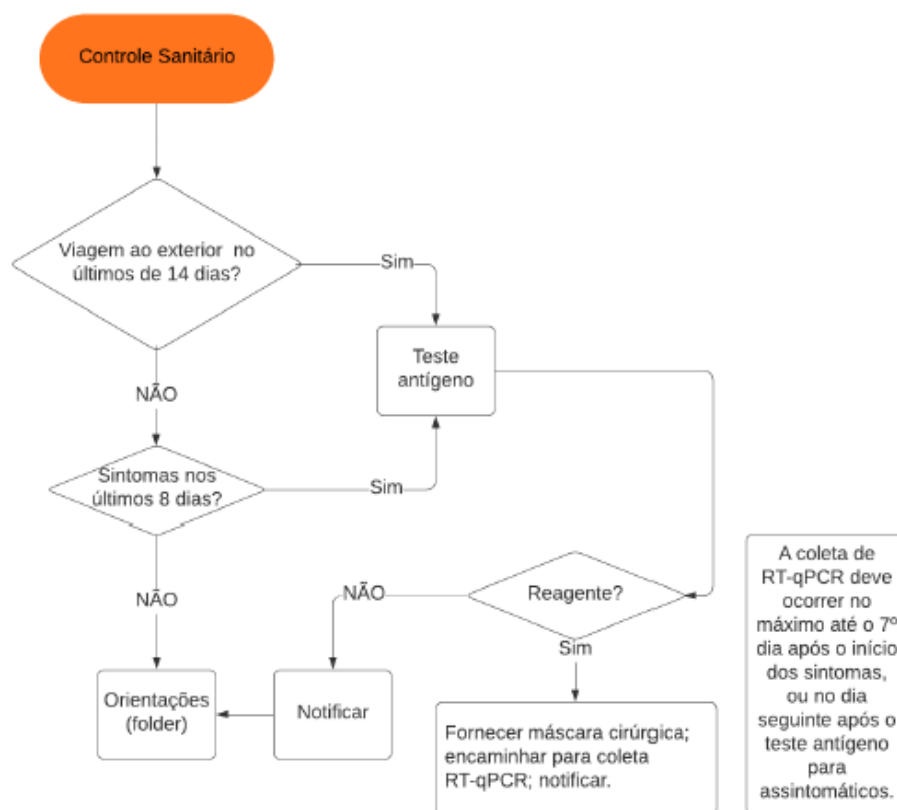
	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 97 de 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



ANEXO 1 - PROCESSO DA AÇÃO DE CONTROLE SANITÁRIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO



	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 98 de 106

ANEXO XII - Nota Técnica Sobre a Variante Delta

COMITÊ CIENTÍFICO DE APOIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



NOTA TÉCNICA SOBRE A VARIANTE DELTA REVISADA EM 09 DE AGOSTO DE 2021

Introdução

Este Comitê Científico, atento à propagação da variante Delta do SARS-CoV-2, vem por meio desta nota renovar esforços de enfrentamento à COVID-19 no Estado, contando com o compromisso e responsabilidade de governantes e cidadãos para fazer frente esse novo desafio.

Nos últimos meses muito temos avançado, com a vacinação já atingido os grupos mais jovens e mais de 50% dos gaúchos vacinados com ao menos uma dose da vacina contra a COVID-19. Entretanto, não podemos baixar a guarda. Será preciso que se redefinam as estratégias locais e que se adotem os protocolos que respondam, a esse novo desafio epidemiológico-sanitário vis-à-vis à preservação da atividade econômica e o desenvolvimento de nossos Municípios e Regiões.

Isto posto:

CONSIDERANDO que a recente mutação do SARS-CoV-2, a linhagem/variante de preocupação Delta (**B.1.617.2**) é a mais recente ameaça de preocupação a saúde pública no mundo e já circula, transmissão comunitária, no RS;

CONSIDERANDO que se estima, por testagem até o final de julho 2021, a existência de 64 casos no RS (sendo 11 casos confirmados por sequenciamento genético completo e 53 prováveis casos identificados por sequenciamento parcial);

CONSIDERANDO a necessidade de redobrar esforços para enfrentar a transmissão dessa variante altamente contagiosa - tanto quanto a varíola - que pode infectar mesmo pessoas totalmente vacinadas; há dados que revelam que 75% dos infectados com a Delta estavam totalmente vacinados (CDC)

COSIDERANDO que pessoas não vacinadas correm um risco 10 vezes maior que adoecer gravemente ou falecer devido a COVID-19;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 99 de 106

CONSIDERANDO que um estudo recentemente realizado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e publicado em pré-impressão no site da MedRxiv, a variante Delta é bem mais contagiosa do que a cepa original do vírus, com uma carga viral 1.260 vezes maior que a do vírus original;

CONSIDERANDO que mesmo pessoas vacinadas, uma vez infectadas pela variante Delta - diferentemente das outras- podem apresentar alto risco de transmitir o vírus à outras pessoas da mesma forma os não vacinados;

CONSIDERANDO que a OMS alerta para o risco de saturação dos sistemas de saúde devido a linhagem Delta;

CONSIDERANDO que o limiar para imunidade populacional varia em função da variante e está subindo. Este limiar é calculado em torno de 60% a 70% para a variante original, 80% para as variantes Alfa e Gama, agora estima-se que o limiar esteja acima de 90% para a variante Delta;

CONSIDERANDO o rápido crescimento da variante Delta em vários países, acarretando num aumento rápido de novos casos e aumento de hospitalizações (de acordo com dados das autoridades americanas e inglesas), mesmo em locais que estão com uma cobertura vacinal mais adiantada em relação ao nosso estado e país;

CONSIDERANDO que, por apresentar sintomas iniciais semelhantes ao resfriado comum as pessoas, em particular as mais jovens, confundem os sintomas da Delta com um resfriado sazonal e, portanto, continuam saindo e se encontrando em grupos para festejar e, assim, transmitindo o vírus ao seu redor.

O Comitê Científico,

RECOMENDA

- Reforçar as medidas preventivas tais como o uso de máscara (em locais fechados e sem ventilação);
- Advertir para a vacinação contra a COVID-19 como medida mandatória para todos os profissionais e funcionários dos serviços de saúde;
- Aumentar a comunicação social sobre a importância da vacinação e dos cuidados quanto ao protocolo sanitário, principalmente sobre os benefícios das medidas não farmacológicas na proteção contra a exposição ao novo coronavírus (ex.: uso de máscaras), a proteção da vacinação a partir da primeira dose, porém a necessidade da completude do regime para uma proteção completa em relação a variantes de preocupação, como a Delta;
- Que empregadores estimulem a vacinação de seus funcionários e a observância do protocolo sanitário;
- Reforçar as medidas sanitárias nas fronteiras, bem como a vacinação nesses locais, em virtude do crescimento de novos casos da variante Lambda, inicialmente descrita no Peru e que vem ganhando espaço nos países vizinhos da América Latina;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 100 de 106

- f) Reforçar a fiscalização de ambientes públicos (**com especial atenção a todos os ambientes fechados**) e de aglomeração, praças e parques das cidades, bem como atentar para o uso de máscara nesses locais;
- g) Reforçar os cuidados em ambientes de sala de aula, em virtude do retorno presencial das escolas e instituições, em um cenário de cobertura vacinal baixa e incompleta;
- h) Reforçar que crianças são suscetíveis ao vírus e, com a presença de uma variante mais transmissível e que pode levar a um aumento substancial na carga viral como a Delta, devemos alertar aos educadores para o reforço dos cuidados quanto ao uso de máscaras, bem como o cumprimento do distanciamento entre as classes, além de manter os ambientes bem ventilados e arejados nos locais de sala de aula;
- i) Realizar uma comunicação clara com a população sobre os riscos dessa nova etapa de enfrentamento da pandemia, e que precisamos que todos façam sua parte e se protejam para protegemos toda a sociedade nessa reta final rumo a cobertura vacinal.

Referências

- 1) CDC/USA, SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. 2021
- 2) Public Health England: Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern: technical briefings. 2021.
- 3) WHO UN: Delta variant, a warning the COVID-19 virus is getting 'fitter and faster', 2021.
- 4) Gov UK: Vaccines highly effective against hospitalization from Delta variant. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/Technical_Briefing_19.pdf

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 101 de 106

ANEXO XIII - Reunião de Alinhamento Anvisa /SMS/Fraport - Controle Sanitário Aeroporto POA

ENC: Reunião alinhamento ANVISA / SMS / FRAPORT - Controle Sanitário Aeroporto POA

Posto Aeroportuario de Porto Alegre <pa.portoalegre.rs@anvisa.gov.br>

Qui, 17/06/2021 06:30

Para: Daniel Chaves <Daniel.Chaves@anvisa.gov.br>; Elizabete de Souza Oliveira <Elizabete.Oliveira@anvisa.gov.br>; Eliane Machado Gomes de Oliveira <Eliane.Gomes@anvisa.gov.br>; Luciana Hollanda de Moraes <Luciana.morais@anvisa.gov.br>; Carlos Roberto Magalhaes Pessoa <Carlos.Pessoa@anvisa.gov.br>; Milene Vargas Lopes <Milene.Lopes@anvisa.gov.br>; Jose Luiz Kloeckner <Jose.Kloeckner@anvisa.gov.br>; Joel Silva Pavao <Joel.Pavao@anvisa.gov.br>; Jordan Jorge Martini <Jordan.Martini@anvisa.gov.br>; Jose Antonio Barbosa da Silva <Jose.Barbosa@anvisa.gov.br>; Maria Ivoni Klafke <Ivoni.Klafke@anvisa.gov.br>; Maria Aparecida Oliveira de Araujo <Aparecida.Araujo@anvisa.gov.br>; Luciana Hollanda de Moraes <Luciana.morais@anvisa.gov.br>
Cc: Mauda Valdeci Vess Rocha <Mauda.Valdeci.Vess.Rocha@anvisa.gov.br>; Luciana Kolm <Luciana.Kolm@anvisa.gov.br>; Suzane Ferreira Suzano <suzane.suzano@anvisa.gov.br>

Prezad@,

Bom dia!

Encaminho para ciência "Reunião alinhamento ANVISA / SMS / FRAPORT - Controle Sanitário Aeroporto POA", realizada em 16/06/2021.

Atenciosamente,

Izaura do A. Streit
PVPAP Porto Alegre

De: Jose Valdemir Barbosa Da Fonseca <j.fonseca@fraport-brasil.com>

Enviada em: quarta-feira, 16 de junho de 2021 14:55

Para: fernandor@portoalegre.rs.gov.br; Izaura de Fatima do Amaral Streit

<Izaura.Streit@anvisa.gov.br>; Euler Jose Monteiro Cavalcante Junior <e.monteiro@fraport-brasil.com>; Gabriela Alves de Freitas <g.freitas@fraport-brasil.com>

Cc: Valerio Augusto Cela Menescal Filho <v.menescal@fraport-brasil.com>; Natalie Servilheira

Valezi <n.valezi@fraport-brasil.com>; Tais Fernanda da Silva Anelo

<tais.anelo@portoalegre.rs.gov.br>; fernandasf@portoalegre.rs.gov.br; Posto Aeroportuario de Porto Alegre <pa.portoalegre.rs@anvisa.gov.br>

Assunto: Reunião alinhamento ANVISA / SMS / FRAPORT - Controle Sanitário Aeroporto POA

Prezados, boa tarde!

Obrigado a todos os participantes na nossa reunião de hoje.

Pontos abordados – Fluxo de passageiros testados positivo:

- Os passageiros testados positivo que não apresentem nenhuma situação de acompanhamento além do programado serão liberados;

- Casos específicos com possibilidades de complicações e que precisem de encaminhamento para atendimento médico serão encaminhados para aguardar a chegada da ambulância nas cabines de atendimento próxima ao desembarque internacional;

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 102 de 106

- Quando o SAMU chegar para retirar o paciente deve seguir o procedimento já existente: estaciona na área das DOCAS e segue para atendimento do cliente nas cabines no desembarque internacional;
- O processo de remoção do paciente é de responsabilidade da equipe do SAMU;
- Após a utilização das cabines para espera de cliente com necessidade de atendimento hospitalar, as mesmas devem ser desinfetadas pela equipe da SMS;
- A SMS irá enviar diariamente – ao final do dia – um relatório com os dados da operação, ou seja, número de testados e quantidade de positivos etc.
E-mails:
pa.portoalegre.rs@anvisa.gov.br – ANVISA
v.menescal@fraport-brasil.com – Operações Fraport
j.fonseca@fraport-brasil.com – Operações Fraport
e.monteiro@fraport-brasil.com – Safety Fraport
g.freitas@fraport-brasil.com – Comunicação Fraport
- Fica liberada a utilização dos sanitários do desembarque por todos os participantes da operação Controle Sanitário inclusive os testadores
- A SMS deve enviar diariamente (por e-mail ou mensagem) a confirmação da retirada do lixo biológico que está armazenado nos sanitários ao lado de fora do desembarque.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Ats,
Jose FONSECA
Terminal Coordinator / Landside Operations
Phone +55 51 3358-2288
Mobile +55 51 99617-9083
j.fonseca@fraport-brasil.com
www.portoalegre-airport.com.br / www.fortaleza-airport.com.br

 Sem título

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destina-se apenas ao destinatário especificado na mensagem. Se você não é o destinatário nomeado, você não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail, bem como utilizar os dados pessoais eventualmente constantes no mesmo. Você não pode usar ou encaminhar quaisquer anexos do e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente se você recebeu este e-mail por engano e o exclua.
Aviso: embora a Fraport Brasil tenha tomado todas as precauções para garantir que nenhum vírus esteja presente neste e-mail, a Fraport Brasil não pode aceitar a responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante da utilização indevida deste e-mail ou anexos ou dados pessoais.

The content of this message is confidential and it is addressed to the recipient specified in the message only. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. You are also not authorized to use the personal data eventually included there. You cannot use or forward any attachments in the email. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.

Warning: although Fraport Brazil has taken all precautions to ensure no viruses are present in this email, Fraport Brazil cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the non-authorized use of this email or attachments or any personal data.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 103 de 106

ANEXO XIV - Ofício-Circular nº. 02/2022 - ANVISA - Procedimentos em caso de contaminação pelo vírus Monkeypox



PROTOCOLO FRAPORT
ANVISA-SBPA-REG-220902-001

Ofício-Circular nº 02/2022/PVPAF-PORTO ALEGRE/CVPAF-RS/CRPAF-PR/GGPAF/DIRE5/ANVISA

Porto Alegre, 02 de setembro de 2022.

À Administradora Aeroportuária, Órgãos Públicos e Empresas que atuam no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre

Assunto: Medidas sanitárias a serem adotadas frente à Emergência de Saúde Pública Internacional causada pelo vírus Monkeypox em aeroportos e empresas aéreas.

Prezados(as),

Mediante o atual cenário epidemiológico solicitamos que as orientações e medidas sanitárias descritas neste ofício sejam adotadas e aplicadas à comunidade aeroportuária, de acordo com o que couber ao seu escopo e função, conforme disposto na Nota Técnica nº 81/2022/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA.

Solicitamos que a Administradora encaminhe este ofício às empresas privadas, que atuam nesta comunidade aeroportuária, e estas deverão orientar suas prestadoras de serviços quanto as medidas aqui postas.

Medidas preventivas para viajantes:

Dentro do escopo de atuação da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras, a RDC nº 21/2008 determina que, mediante análise das informações em saúde realizada pelo Ministério da Saúde for identificado risco à saúde que configure uma situação de emergência de saúde pública de importância internacional.

As medidas sanitárias estabelecidas serão adotadas de forma a garantir a sua aplicabilidade nas áreas de fluxo de viajantes. Portanto, considerando que, no momento, não há orientação para restrições de viagens devido à essa doença, orienta-se que os viajantes atentem para sinais e sintomas dessa doença e evitem realizar viagens não essenciais caso apresente-os, procurando orientação de profissional de saúde na localidade em que se encontra.

Os administradores de portos e aeroportos e operadores de meios de transporte devem apoiar a divulgação das orientações e materiais informativos disponibilizadas no sítio do Ministério da Saúde e da Anvisa.

Salientamos que as ações nos pontos de entrada de viajantes permanece sendo o monitoramento de casos suspeitos para doença causada pelo vírus Monkeypox e rastreamento de contatos. Assim, devem ser amplamente divulgados os sinais e sintomas relativos a essa doença para manejo de casos. Atualmente, a definição de casos atualizada pelo Ministério da Saúde é:

Caso suspeito

- Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.

Caso provável

Caso que atende à definição de caso suspeito, que apresenta um OU mais dos seguintes critérios listados abaixo, com investigação laboratorial de monkeypox não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico de monkeypox não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico.

- a) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU contato físico direto, incluindo contato sexual, com parceiros múltiplos e/ou desconhecidos nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; e/ou
- b) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU história de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; e/ou

Posto de Vigilância Sanitária de Porto Alegre/PVPAF PORTO ALEGRE/CVPAF-RS
Av. Severo Dullius n.º 90010 Cep.: 90200-310 Porto Alegre/RS Fone: (51) 3371-4849
E-mail: pa.portoalegre.rs@anvisa.gov.br

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 104 de 106



- c) Contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes a um caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; e/ou
- d) Trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) com história de contato com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Caso confirmado

Caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para Monkeypoxvirus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).

Caso descartado

Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento) OU sem resultado laboratorial para MPXV E realizado diagnóstico complementar que descarta monkeypox como a principal hipótese de diagnóstico.

Informamos que com base nas informações disponíveis até o momento, não é recomendada nenhuma restrição para viagens e comércio para países que identificaram casos dessa doença. No entanto, para o apoio às investigações epidemiológicas, poderá ser solicitado lista de passageiros por meio do sistema SISBRAIP, notificação à companhia aérea em casos que se fizer necessário.

O plano de contingência local deverá ser revisado e atualizado, de modo a contemplar os protocolos específicos para atendimento de eventos de saúde pública relacionados a Monkeypox, para o atendimento de Eventos de Saúde, atentos aos sinais e sintomas que tenham características típicas da doença causada pelo vírus Monkeypox, conforme definições acima descritas, independentemente do histórico de viagens.

Descrição das ações e atividades:

Definição de alinhamento de abordagem conjunta entre operadores, administração do ponto de entrada, serviço de atenção à saúde, autoridades que atuam no aeroporto na vigilância epidemiológica, se caso identificado no voo:

ANTES DO POUSO

1- O Comandante da Aeronave ao tomar conhecimento do fato deverá:

- Notificar o evento à Torre de Comando;
- Adotar, na aeronave, as medidas recomendadas pela Autoridade Sanitária e apoio médico;
- Informar, de imediato e quando houver alteração, ao Órgão de Controle de Tráfego Aéreo os seguintes dados: i. Número de viajantes com a suspeita; ii. Sinais e sintomas; iii. Estado geral do caso suspeito; iv. Dados dos casos suspeitos (nome, idade, sexo, assento); v. Se caso suspeito viaja só ou em grupo; vi. Tipo de aeronave; vii. Tempo estimado de voo até o pouso; viii. Autonomia de voo.

2. Torre de Controle deverá:

Repassar imediatamente estas informações ao Centro de Operações de Emergência – COE do aeroporto de destino.

3. O operador do COE deverá:

- Receber a informação e comunicar imediatamente à Autoridade Sanitária – ANVISA, ao serviço médico e à companhia aérea;
- Após os acionamentos acima informar à VIGIAGRO, Receita Federal, Polícia Federal e ANAC, se couber.

4. O centro de operações deverá:

De acordo com a avaliação de risco, realizada pela autoridade sanitária, indicar à Torre de Comando (TWR) o local de estacionamento da aeronave, optando pela posição a ser definida em conjunto com o órgão de vigilância sanitária.

5. A administração aeroportuária deverá:

- Coordenar as ações que se fizerem necessárias, em conformidade às orientações da autoridade sanitária e a equipe médica do aeroporto;
- Disponibilizar, em caso de necessidade de segregação dos passageiros contactantes, a área de triagem;
- Verificar junto à Polícia Federal e a Receita Federal a forma de efetuar o controle migratório e alfandegário do caso suspeito e demais passageiros contactantes, se couber.

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 105 de 106



APÓS O POUSO

1. À companhia aérea, compete:

- Fornecer à Autoridade Sanitária, sempre que solicitado, a lista de passageiros do voo, os dados sobre os viajantes disponíveis nos sistemas da Cia, a Declaração Geral da Aeronave e o registro de atendimento médico a bordo;
- Garantir que seus funcionários ou terceirizados façam uso de EPI de acordo com a orientação da Autoridade Sanitária;
- Acompanhar o passageiro segregado até o hospital referenciado, quando necessário, conforme orientação da autoridade sanitária;
- Segregar a bagagem dos casos suspeitos e dar o tratamento conforme orientação da Autoridade Sanitária;
- Apoiar a autoridade sanitária na comunicação junto aos viajantes.

2. À Equipe médica do aeroporto, compete:

- Comunicar a autoridade sanitária, imediatamente, quando houver suspeita de doença infectocontagiosa;
- Paramentar-se com os EPI adequados, antes de entrar em contato com o caso suspeito (Plano Nacional);
- Avaliar os sinais e sintomas do viajante a bordo, após a autorização do comandante e da autoridade sanitária;
- Avaliar os critérios clínicos para enquadramento como caso suspeito, de acordo com a definição do Ministério da Saúde;
- Realizar o atendimento médico na ambulância (pátio) ou ainda na própria aeronave, de acordo com as condições clínicas do caso suspeito;
- Desembarcar o caso suspeito e seus contactantes pela porta que possibilite o menor cruzamento possível com os demais passageiros, conforme orientação da autoridade sanitária;
- Encaminhar o caso suspeito para o serviço de saúde apropriado, conforme orientações da autoridade sanitária.

Por fim, as medidas acima preconizadas possibilitarão a identificação precoce de casos suspeitos e isolamento recomendado, assim como compartilhamento de dados de contatos próximo em atuação coordenada com os demais entes envolvidos de forma a viabilizar o monitoramento e evitar a disseminação do vírus.

As recomendações continuarão a ser atualizadas de acordo com a evolução do cenário epidemiológico e definições do Ministério da Saúde/ANVISA.

Atenciosamente:

IZAURA DE FATIMA DO
AMARAL STREIT:30599768053

Izaura de Fátima do Amaral Streit
Chefe do PVPAF Porto Alegre/CVPAF/RS

	PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PORTO ALEGRE AIRPORT	Rev. nº 02 13/09/2024
	FB-EM-POA-PL22001	Pág nº 106 de 106

ANEXO XV - Ofício-Circular nº. 15/2024 - ANVISA - Encaminha a Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA - Atualização de medidas em pontos de entrada frente à vigilância de casos de mpox na Região da África.

27/08/2024, 13:55

SEI/ANVISA - 3122401 - Ofício Circular



Quinta Diretoria
Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados

OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2024/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA

Representantes dos Setores Aeroportuário e Portuário

Assunto: Encaminha a Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA - Atualização de medidas em pontos de entrada frente à vigilância de casos de mpox na Região da África.

Referência: Caso responda este Ofício Circular, indicar expressamente o Processo nº 25351.913049/2022-99.

Prezados(as) Senhores(as),

- Com meus cordiais cumprimentos, encaminho, para ciência, divulgação e providências pertinentes, a Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA, elaborada pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (COVIG/GGPAF), e que trata da atualização de medidas de vigilância epidemiológica em Portos, Aeroportos e Fronteiras frente à intensificação da vigilância de casos de mpox, em relação à nova variante do clado I, circulando na Região da África.
- A Nota Técnica faz uma análise do cenário epidemiológico nacional e internacional relativo à doença, além de definir as recomendações e orientações a serem adotadas nos pontos de entrada, diante da atual declaração de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII) para mpox, em 14/08/2024, feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
- Esclareço que as medidas de saúde indicadas na Nota Técnica foram avaliadas para o presente cenário epidemiológico da mpox no Brasil e no mundo, sendo proporcionais e restritas ao risco, mas que poderão ser revisadas e alteradas caso haja mudanças no contexto epidemiológico da doença.
- Portanto, peço a gentileza de que levem ao conhecimento de todos os envolvidos as orientações constantes na mencionada Nota Técnica.
- A Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF) agradece a costumeira colaboração de ambos os setores.

Atenciosamente,

Bruno Gonçalves Araújo Rios
Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados
GGPAF/DIRE5/ANVISA

Anexos: I - Nota Técnica nº 14/2024/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA.
II - Alerta Epidemiológico Mpox (MPXV clado I).
III - ALERTA DE EVENTO INTERNACIONAL.
IV - Nota Técnica 29/2024-DATHI/SVSA/MS.